

9주차 SUMMARY

위완^{胃緩}

1. 개요 교과서 p. 150

- 위완^{胃緩} = 완복비만, 애기불서, 위완동통, 장명록록, 대변부조 등 비위실조를 특징으로 하는 병증
* 緩 늘어질 (완) - 즉, 위가 기질적으로 아래로 늘어지는 것 (=위하수!)
- 본래 품부가 박약하고 장기간의 음식실조, 칠정내상, 노권과도 등으로 인해 중기하할하고 승강실상하여 발생
- <<內經>> 전신 기육이 견실하고 크면 위가 두껍고, 기육이 가늘고 빈약하면 위가 얇으며, 기육이 신체와 균형을 이루지 않으면 위의 위치가 아래로 쳐져 있고, 기육이 견실하지 않으면 위가 늘어진다 = 위완
- 서양의학의 위하수, 기능성 소화불량증, 위장관 운동장애와 유관
- 만성적 기능 쇠약으로 인해 발병하므로 장기치료가 요구됨
- 치료 시 음식조절, 정신적 안정 및 적당한 운동 등이 치료 효과에 영향 미침

2. 병인병기

- 脾胃失和: 음식실조, 칠정내상, 노권과도
- 음식과 칠정, 노권 등은 인체의 기육을 소박하게 함 + 비위실화로 인한 납식감소
→ 형체 더욱 소박해지고 기육은 견실하지 못해 위완 형성
- 이 외) 선천적 품부 박약 or 분만 후 복벽이 이완하여도 기육이 견실하지 못해 위완 형성 등

曰)

- 여성과 노인에게 多發
- 복부 수술 기왕력이 중요하므로 문진 시 수술 여부 물어봐야 함!
- 속이 더부룩하고 위완통이 있다고 내원하였을 때 노인분이거나 갱년기 질환을 앓고 있는 사람이라면 동일 증상이라도 위완일 수 있음

3. 진단 및 감별진단

✓ 진단 [기출] 위완의 임상증상과 감별진단을 쓰시오

- 위완의 진단은 주로 임상표현에 근거함 - 총 5가지 (아래표)
- 환자는 대부분 품부가 박약하고 몸이 몹시 여윈 체질
- 혹은 장기간에 걸친 음식부절, 칠정내상, 노권과도 등으로 몸이 수척해진 사람임
- 아동은 비교적 적음

완복비만	• 식사 후 복부 창만해지며 심하비만을 겸함 • 위치가 고정되어 있으며 창민의 자각이 심함 but 외형은 창만 X • 병리기전) 비기하함의 正虛가 있으면서 또한 기기조색의 氣滯가 존재 • 심하면 어혈조체의 복만도 존재함
애기불서	• 완복비만과 동시에 존재함 • 기기조색하고 비위실화의 소치이다. • 비기가 상승하지 못하면 위실통강하고, 위기가 하강하지 못하면 비기상승에 영향을 미침 • 위기가 상역하므로 트림을 해도 시원하지 않으며 심하면 오심구토 함
위완동통	• 식후에 鑿痛추통이 나타나고 平臥평와하면 추통이 소실됨 밥 먹고 나면 배꼽 위에 나타나기도 함 - 절대 과식하면 안됨!
장명록록	• 비위의 양기가 쇠약하여 수음이 위에 정체하였다가 아래로 장문으로 주행하므로 꾸르륵 꾸르륵 소리가 나는 것 (꼭 나타나는 증상은 아님)
대변비조	• 기허하여 운행이 무력하여 나타남 or 위의 진액이 손상된 소치 1) 위실화강하며 위납감소하고 구토하여 진액 손상 시 위음이 줄어들 2) 온조한 약을 지나치게 사용 시 위음이 모르는 사이 조금씩 손상됨 (꼭 나타나는 증상은 아님)

애기불서 Case)

입원 환자 中 한 환자: 예전에 20년 전에 위의 절반정도 위완수술 후 완치 판정 받았음

이후 식사량 줄고 더부룩한 느낌이 많이 들. 구토 때문에 내원함.

교수님께서 환자에게 식사를 다섯 번에 나눠 먹게 하고 최소 30분정도 식사하게끔 하였는데도 증상 지속됨
알고보니 친정엄마의 과도한 간섭 때문에 예전에 받았던 트라우마들로 인해 발병한 것

(나이 꽤 있는 아저씨 환자였는데도 아직도 팬티 뽀 색 입어라 등 관여함;)

삼위일체 변증법: 세가지 변증을 동시에 사용하여 소화기 질병을 효과적으로 치료하는 변증

- └ 임상변증: 임상 증상을 보고 변증하는 것
- └ 미관변증: 내시경을 통해 위 점막의 출혈, 발적 등의 상태를 확인하는 것
- └ 체질변증: 환자의 체질을 보고 변증하며 체질에 따른 처방을 해줌

[기출] 임상변증과 미관 변증이 일치하지 않는 이유와 이를 보완할 수 있는 방법을 쓰시오

- 인체의 정체관적 반응성과 국부의 병변 간 차이가 있기 때문
- 임상 변증으로 치료 시 효과가 없을 때 위 점막의 미관변증을 고려해 치료할 수 있음

✓ **감별 진단** [기출] 위안의 임상증상과 감별진단을 쓰시오

- 주요 증상은 **완복비만**과 **위완동통**
- 위안의 완복비만은 대부분 식후에 나타나고 창급동통을 수반하며 혹은 상복부에서 항상 어떤 형체를 감지할 수 있음
- 위안의 위완동통은 밑으로 처지는 통증(墜痛)으로 바로 누우면 통증이 경감 또는 소실되며, 서 있거나 활동하면 심해짐

- + 복근 있는 사람들은 대체로 소화기 증상이 잘 없음. 코어 근육이 발달했기 때문
- = 환자들 복진 시 코어 근육이 매우 약함
- + 20~30대 미혼자들 중에 하수 증상이 대체로 많이 나타남 (왜 그런진 모르겠다고 하심)

4. 변증요점

- ① **허실을 살핀다**
 - 기육불견의 소치로 비주기육하므로 비기하함으로 인함
 - but 기체, 어혈, 담열 등을 끼고 있으므로 표본동치 해야 함
- ② **한열을 가린다**
- ③ **기혈을 구분한다**
- ④ **윤조를 살핀다**
- ⑤ **승강을 저울질한다**
 - 비는 운화와 상승을 주재 / 위는 수납과 하장을 주재
 - 위주강이 안되어 나타나는 증상과 비주승이 안되어 생기는 증상들을 구별해야 함

5. 치료 원칙 [기출] 위안의 치료원칙과 조리방법에 대해 쓰시오.

- | | | | |
|------|---------|------|---------|
| ① 익기 | ③ 化飲 화음 | ⑤ 행기 | ⑦ 養陰 양음 |
| ② 승양 | ④ 강역 | ⑥ 활혈 | ⑧ 開滯 개설 |

- # 강역: 위의 화강이 실조하여 위기가 상역하여 구토하거나 트림을 함
- 속이 미식거린다고 했을 때 위에서 나타나는 증상이므로 소화기 쪽에서 많이 응용
 - 소화기뿐만이 아니라 다른 질환 일차적인 증상/원인에 따른 증상일 수 있으므로 환자가 오심을 호소하면 오심구토를 일으키는 질환들을 다 체크해줘야 함

6. 변증시치 비허기함과 위음부족만 언급하심

1) 비허기함 [기출] 위안의 변증시치 중 비허기함의 증상, 치법, 처방을 쓰시오.

증상	면색위황 / 정신권태 / 불사음식 / 식후완복비만 / 애기불서 / 嘔腹脹而墜 흑구토청수담연 / 기육소약 / 설담태백 / 맥완약
치법	보기승함
처방	보중익기탕 합 지출환 (+황련, 지실)

2) 위음부족

증상	면색약홍 / 순홍이조 / 구고구취 / 번갈희음 / 애기빈번 / 흑오심구토 / 식후완복창만 / 빈민불서 / 대변건결 / 설홍진소 / 맥세삭
치법	유양위음
처방	익위탕 합 일관전

3) 기체혈어 나머지 내용은 책 참고..!

4) 속식정음

7. 경과와 예후 pass하심

8. 예방과 조리 [기출] 위안 환자의 예방과 조리법에 대해 쓰시오.

- 체력을 단련하여 근력을 증강시키면 도움이 됨
- 음식영양에 주의: 영양 풍부, 소화가 잘되며 체적이 작은 음식 선택 / 동물성 단백질과 지방질의 섭취를 많이 함 / 채소, 쌀, 국수 등은 조금 적게 먹음
- 조금씩 자주 먹음 / 폭음폭식 X / 식후에 잠시 누워서 쉬
 - ↳ 위안의 추통이 너무 심할 때에는 누워 있음 (오른쪽으로 30분 정도)

위하수

1. 개요 프린트

정의	위의 위치가 정상위치보다 하강되어 있는 것
판정	X선 검사상 조영제를 섭취하고 서서 찍었을 때 충만되어 있는 위의 굽어진 각이 장골릉의 정점을 연결하는 선 아래로 내려 쳐질 정도로 위가 늘어나 있을 때 위하수 판정
원인	[기출] 위하수가 잘 발생하는 체질을 쓰시오. - 소음인형 무력체질 (+ 아래 내용) ① 선천적 체질 허약으로 원기 부족 + 흉곽 細長 + 하복부각 예각 ② 복벽의 이완 or 복강 장기의 전위가 될 동기: 임신, 출산, 복벽근육 결손 ③ 위암, 위확장시에 중량으로 인하여 위 하강 ④ 동양인 > 서양인, 여자 > 남자
증상	① 명치부근 압박감, 정체감, 불쾌감 ② 초기에는 식후에 증상이 나타남 → 심해지면 항시 증상O, 공복감 느끼지 못함 ③ 공복감이 있어 조금만 먹어도 꽉 찬 느낌이 듦 ④ 억지로 먹으면 메스껍고 구토함 + 위에 둔통, 식욕감퇴 ⑤ 속 쓰리고 트림이 남 (위산과다로 오인하기도) ⑥ 권태, 피로 + 병에 대한 불안감으로 인한 우울증, 불면증 ⑦ 저혈압, 두중감, 현기증, 견비통, 동계 + 흥분하기 쉬움 ⑧ 목에 무엇이 걸린 듯한 느낌, 손발의 저린감 ⑨ 타각증상: 위의 하단은 양와위에서도 배꼽 또는 그 하단에 있고, 소만부상선도 하방으로 이동된 것을 촉진할 수 있음

2. 진단

- 소음인 多
- 기립위에서 하복부간전부가 팽출하여 복진으로 제하부에서 위가 촉진됨
- 호흡 시 위의 승강이 시진상 외부로 나타나기도 함
- 위의 X선 검사: 위의 긴장 저하 및 위내용물의 배출시간의 지연이 특징
- 위내시경검사: 위축성 위염을 많이 보이며 위액검사에서는 저산증이 많음

3. 분류 읽어봐라

분류	기준: 장골릉의 정점을 연결하는 선	
	위소만곡	위대만곡
1도	1.5cm 이내	6.5~8.5cm
2도	1.6~4.5cm	8.6~11cm
3도	4.6cm 이상	11cm 이상

4. 감별진단

위확장	위하수
위의 하계는 하강하나 상계는 원위치	상계, 하계가 같이 하강
토물량이 많고 산성이며 부패함	구토는 있으나 토물이 적고 부패 X
새벽 기상 시 위중에 잔사감 O	새벽 기상 시에 위가 비어 있음

5. 치료 **[기출]** 위하수를 진단받은 환자의 치료법은?

- ① 과식 피하기 / 식사는 소량씩 여러 번 나누어 하기
- ② 식후에 30분 정도 와상 휴식 취하기
- ③ 소화 장애 초래하는 음식 피해야 함
- ④ 복대를 장기간 사용하는 것이 좋다 (X)
↳ **NO..** 오래할 경우 기립근, 장요근 등이 약화될 수 있으므로 식후 잠깐씩만 해줘야 함
- ⑤ 치료약: 승거제 + 거담, 행기, 건위, 소도약을 겸하여 씹 / 체질에 따라 사상방 쓰기도 함
- ⑥ 무력감과 합병증 있을 때는 약물 자체를 소화시키지 못하는 경우가 많으므로 침구요법을 병용하는 것이 좋은 방법

[기출] 위무력, 위하수 치료 시 통치방 5가지 이상을 쓰시오

답) 보중익기탕, 익위승양탕, 보기건비탕, 부자이중탕, 황기탕, 진무탕, 복령음, 향사육군자탕, 화음양비탕, 가미소요산 등

위무력증

1. 개요 프린트

정의	- 위벽의 근긴장이 쇠약해진 상태 - 증상에 불과한 것으로 질병은 아님 - 위하수, 위산결핍증이 함께 오거나 그렇지 않으면 그 어느 한 가지와 겹쳐서 일어나는 경우 多
원인	① 선천성 근육박약에 의한 것이 많음 (무력성 체질) ② 과식하는 습관이 있는 사람에게 많음 = 위의 과도한 사용으로 위근의 기능부전으로 위무력됨 ③ 약물의 남용: 하제, 모르핀, 아트로핀 등의 남용으로 야기되기도 함 ④ 전신신경증(신경쇠약, 히스테리 등)의 한 증후로서 출현되는 수도 있음
증상	① 자각증상: 위부팽만감, 식욕 이상은 없음 ② 섭취 후 위부팽만감을 두려워하여 절식하기 때문에 현저한 체중감소 O ③ 애기와 오심을 항상 느끼게 되지만 구토는 간혹 나타남 ④ 장관도 무력상태가 될 때가 많으며 이 때에는 변비가 생김 ⑤ 중증: 두통, 현훈 등

2. 진단

- 소음인의 무력체질
- 복진상 위부 특히 위대만의 팽릉을 보게 되며 환자의 복벽이 부드럽고 얇을 때는 위형의 복벽에서도 촉진할 수 있다.
- 공복 시 위의 크기는 건강 시와 별 차이가 없으나 식후에는 뚜렷하게 증대되는데 손 끝으로 타진하면 잔재성 진수음을 발생하여 음식물이 오랫동안 위 내에 저류됨을 알 수 있다.
- 우관맥이 부어이지한 경우가 많음

3. 감별진단

유문협착	대부분 Atony증과 위확장을 수반하여 진수음을 발생하며 위벽경직, 연동항진, 구토 등을 나타냄
만성위염	보통 위의 확장 수반 X 배출장애도 X
신경성 소화불량	증상이 부정해 시간, 장소에 따라 변동됨. 그 변동은 음식물의 질/양과 관계 없고 신경쇠약 증후가 있음

4. 치료

- 선천적인 것은 체질을 감별해 체질을 개선
- 식사: 너무 장기간 유동식을 주어 위벽의 긴장력을 완화시키는 것보다 소량의 고형식이라도 자주 주어서 위의 긴장력을 길러 주어야 함
- 정신적인 과로를 피하고 가벼운 운동 필요
- 약물치료: 건비, 소도, 자운을 원칙으로 함

[기출] 위무력, 위하수 치료 시 통치방 5가지 이상을 쓰시오

1) 통치방: 평위산가향부자, 곽향 사인, 양위진식탕, 향사양위탕, 황계육군자탕, 보중익기탕, 령계백감탕, 인삼양위탕

2) 사상방 / 고방

⇒ but 근본적으로 운동시켜야 함!

5. 경과 및 예후

- 만성적 경과를 보이며 식사의 규칙, 정신수양, 적당한 운동을 행하면서 치료하면 양호하나, 약물에만 의존하면 상당한 장기 치료를 요하게 된다.

구미이상 口味異常

1. 개요 교과서 p. 103

- 구미이상 = 입안에서 항상 감/고/산/염/취 등의 기미를 느끼는 것
- 그 외 구갈, 구점, 구삽 등의 증상도 구미이상의 범주에 속함
- 서양의학에서는 구미의학을 미각결핍, 미각감퇴, 미각장애 등으로 분류
↳ 부신피질기능장애, 갑상선기능저하, 비타민 결핍 등으로 발생할 수 있음
- 심한 화상 or 각종 중병 및 수술 후에는 모두 음식무미를 느낌

담도질환	소화성 궤양	이하선염	요독증	정신신경병
구고증	구산증	구염증	구취증	기과 미각
당뇨환자	구감증 (당뇨병성 케톤증일 경우 썩은 사과 냄새가 남)			

- + 미각과 관련된 삼차신경, 안면신경, 설인신경의 이상일 수도 있음
- + 코로나 이후 미각 이상 호소하는 사람도 생김
- + 뚜렷한 원인 찾기가 어려워 치료기간이 대개 길고 완치가 적음

2. 구미이상의 분류 (11개) 日 반드시 외워라..!

[기출] 구미이상증의 11가지 분류를 쓰시오.

▶ 구감 구고 구산 구함 구담무미 구점 구취 가삽 구갈 구성 구향

1) 口甘 구감 = 口甜

정의	일종의 자각증상으로서 입안에서 항상 단맛이 느껴지는 것 ↳ 맹물을 마셔도 단 것을 느낄 수 있음 = 비열의 소치
병인병기	주로 노관과다, 사려불수, 방사불절, 과식비감으로 발병 실증) 비열, 위열, 음식열독, 외감사열이 온적한 소치 허증) 비허나 비신량허의 소치 - 본래 허약하거나 사열이 진액을 작상하여 형성
변증시치	① 비열구감: 청비사화(치법) / 사황산, 청위산 (처방) ② 비허구감

2) 口苦 구고 ★ 구취와 함께 가장 많이 나타나는 것

정의	- 입맛이 쓴 것 - 膽瘴(담단)의 주요 증상
병인병기	① 상한의 태양병이 풀리지 않아 사기가 소양에 전하면 담은 소양지부이므로 담열이 상증하여 발생 ② 정지울결하거나 오지과극으로 인해 간담울화가 안에 쌓이면 소설 기능이 실조항 담기가 위로 넘쳐 발생
변증시치	① 邪在少陽 ^{사재소양} : 和解소양(치법) / 소시호탕(처방) ② 간담울열 + 심열에 의해 생기기도 함 : 심열구고생창 환자들 多, 입이 쓰고 구내염이 자주 생기는 사람 : 건중탕류, 보중익기탕류, 탁리음 → 십전대보탕 등

日)

- 일시적인 경우가 많음 + 호전되는 경우도 많음
- 면역력이 약한 사람에게 많이 나타남
- 입이 쓴 경우에는 생창, 역류성 식도염 등이 있으므로 잘 감별하여 치료해야 함
- 인후 불편감: 역류성 식도염 or 만성 편도 비대(=만성 피로감, 지속적 염증, 오후열감, 허열)

3) 口酸 구산

정의	입안에서 신맛이 느껴지는 것 - 심하면 말할 때 신 냄새가 남 cf) 탄산: 위중의 신물이 위로 올라오는 것
병인병기	① 간의 실열: 정지억울로 화화생열하거나 사열이 간담에 쌓이면 간열이 위로 훈증하여 산미가 나타남 ② 脾虛木乘구산: 비허한데다 간목이 승비하여 구고하는 경우로, 병이 본래 비에 있어 허실협잡한 증상이 나타남 ③ 속식정체: 음식을 많이 먹거나 비감후미한 음식을 과식해 비위의 운화에 영향을 미쳐 발생
변증시치	① 간열구산 ② 비허목승구산 ③ 속식정체구산

4) 口鹹 구함 (鹹-腎의 味) 원인을 아는 데 실패하는 경우 多

정의	입안에서 짠맛이 자각되는 것으로 때로는 담연의 배출을 동반함
병인병기	- 신액이 올라온 소치로 모두 신허에 속함 - 음허 / 양허 - 음허: 주로 허화상염하여 신액을 전작하기 때문 - 양허: 양허불섭으로 신액이 상범하기 때문 - 병인) 신의 勞傷, 年高體衰, 구병급신 등으로 下元허쇠를 초래하여 진음진양이 손상을 받아 형성
변증시치	① 신음허 ② 신양허

5) 口淡無味 구담무미 구안와사 환자와 동시에 같이 오는 경우 多

정의	- 입안에 미각이 감퇴된 것으로 입안에서 담담한 맛이 발생하고 음식의 맛을 자각적으로 느끼지 못하는 경우 - 일반적으로 납곡불향 식욕부진 등의 증상 동반
병인병기	① 비허불운: 음식부절, 大吐大瀉, 구병실양 등으로 인해 비위의 기가 허해져 운화와 전수 기능이 상실되므로 발생 ② 습조불운: 외습이 비위를 침습하거나 음식소상으로 인해 비운불건하면 습탁이 내생하여 중초를 막아 발생
변증시치	① 비위허약구담 ② 습조중초구담

6) 口粘 구점 = 口膩

정의	입안이 끈적하여 상쾌하지 않는 일종의 자각증상
병인병기	- 대부분 비온습열의 소치 or 간혹 비허실운, 신진액설로 발생하기도 함 ① 실증: 외감 or 내상으로 습탁불화하고 구설에 저체하여 생김 ② 허증: 비허나 신허의 소치 - 비허하여 涎을 통제하지 못하면 발생 - 대개 크게 놀라거나 무서워하면 신기가 상해 신액이 외설하여 타액분비 ↑
변증시치	① 실증구점 ② 비허구점 ③ 신손구점

日) 노인분들 틀니하는 경우 식욕부진과 함께 구점이 존재할 수 있음

7) 口臭 구취 ★

정의	입에서 穢臭가 나오는 것을 자각하거나 타인이 느끼는 경우
병인병기	- 구강질환(구내염, 충치), 코질환(축농증), 인후질환(편도선염) 등에서 나타남 ① 위열상증: 온열병이나 구창, 아토피 등의 병에서 흔히 출현 or 평소에 신라후미를 먹어서 내열이 발생하면 화열이 상증하여 구취 발생 ② 장위식적: 음식부절 → 장위실운 → 속식정체 → 속적 형성 → 구취 발생 ③ 담열옹폐: 폐열, 폐옹 등의 병이 있을 때 나타나며 담열이 옹폐하여 작상기혈하면 어결성옹하여 혈패위농하기 때문에 구취 발생
변증시치	① 위열상증구취 ② 장위식적구취 ③ 담열옹폐구취

아래부터는 교수님께서 언급만 하고 넘어가셔서 간략하게 정리하겠습니다.

8) 口澀 구삽

- 입안이 텅은 것
- 조열이 폐위진액 손상 시 발생
- or 水氣가 말라서 화기가 타고르고 기혈이 어결하면 진액이 상승하지 못하므로 발생
- 변증) ① 폐위津傷구삽 ② 폐신음허구삽

9) 口辣 구랄

- 매운 고추를 먹은 것처럼 입안에서 매운 맛을 느끼며 아리는 것을 말함
- 상화가 망행하여 진액을 혼증하고 담을 불리어 심담을 요동케 하면 발생
- 변증) 상화담탁구랄

10) 口腥 구성 日) 거의 못 봤음

- 입안에서 피비린내가 나는 것을 말함
- 폐기울체하고 충임맥이 불조하면 발생 or 폐위에 열 쌓여 위로 규락을 침입해 발생
- 변증) ① 간울기체구성 ② 폐위적열구성

11) 口香 구향

- 입안에서 향내가 나는 것
- 噯氣에서 쉼은 사과 향기가 나는 것은 소갈증의 중증(당뇨병)
- 담열이 안에서 요란하여 담이 결단력 상실해 위가 화강하지 못해 향내가 남
- 변증) 담열내요구향

구취

1. 개요 교과서 p. 253

정의	- 구강, 비강을 통해 나오는 악취 / 입에서 나는 불쾌한 냄새 / 생리적 병적인 원인에 의해 구강 및 전신으로부터 발생하는 불쾌한 호흡에 대해 정의할 수 있음 - 우리 몸에서 나는 여러 체취 중 하나로서 몸의 다른 부위에서 나는 냄새와 유사
원인	- 구취는 세균의 부패작용에 의한 산물 - 세균 부착하기 쉬운 치태 축적에 이상적 환경인 “혀” - 혀에 혐기성 그람음성 세균들이 타액/음식물에 포함된 단백질과 펩타이드에 작용하여 냄새를 풍기는 휘발성 황화합물(VSC)을 생성하여 발생
부위	- 주로 구강 내 부위 중 혀, 치은연하에서 발생 (혀가 가장 중요 - 60% 유발) - 혀의 배면 후방에서 발생한 냄새는 치은연하 치태에서 발생한 냄새와 다름

2. 분류 및 원인

✓ 분류

- └ 병적인 구취: 구강상태 및 전신질환에 의해 발생
- └ 생리적 구취: 정상적으로 발생
- └ 주관적 구취: 객관적인 증상은 없지만 자신에게 구취가 있다고 느끼는 주관적 구취

✓ 원인 [기출] 구취의 원인을 구강내 원인과 구강외 원인으로 분류하시오.

구강 내 원인	외상성 궤양 / 치성농양 / 헤르페스 감염 / 아프타성 궤양 / 구강 칸디다증 / 구강감 / 치은염 / 치주염 / 치아우식증 / 불량한 보철물 등
구강 외 원인	- 정상적인 생리적 냄새: 연령, 공복, 아침기상, 월경, 음식물, 흡연 및 약물 - 비인두 및 호흡기계 질환: 부비동염, 편도선염 - 간 및 신장질환: 간경화증, 요독증 - 소화기질환: 역류성 식도염, 열공, 헤르니아, 게실 - 전신요인: 수분부족, 비타민 결핍, 스트레스

3. 치료

☞ 소달건비탕 消疸健脾湯

- 주증: 諸疸를 통치하며 곡달로 음식이 소화되지 않으며 불능음식하며 번심하고 흉복창만하는 증상에 씀
- 소화불량, 가슴답답, 기능성 소화불량증 양상 + 간기울결 간기범위 우울증 화병 (비계내과에서 가장 많이 쓰이는 보비탕 다음으로 많이 쓰는 처방임)
- 향부자 인진 산사육 창출 백출 박하 진피 저령 택사 적복령 산치자 나복자 곽향 반하 삼릉 봉출 청피 대복피 감초
- 간담습열증에도 많이 쓰고 역류성 식도염에 가감해서 쓴다.

☞ 간담습열방

- 알코올성 간염, 간경화, 간수치 많이 높은 환자들에게 씀 - with 가미
- 거의 대부분 이걸 쓰면 간수치가 잘 떨어짐 + 간세포 파괴 막는 처방
- 갈화 인진 지구자 백출 택사 갈근 진피 황련 저령 대복피 후박 사인 곽향 초두구 목랑 감초 봉출 삼릉
- 백두구, 치자, 후박 안 써도 됨

10주차 SUMMARY

애역 呃逆

1. 개요 교과서 p. 109

정의	“딸꾹질” 횡격막 경련으로 발생하는 것 - 기가 거꾸로 치밀어 올라 喉部(후부)에서 짧고 잦게 소리를 이어서 내는 것 - 사람이 스스로 억제하지 못하는 병증
특징	- 단독 발생하기도 하고 다른 병의 겸증으로 나타나기도 하며 연속 or 간헐적 발작 - 우연히 발작된 것은 경미한 것으로 약을 쓰지 않아도 저절로 낫게 됨 - 계속 끊이지 않는 것은 적절한 치료가 필요 (경우에 따라 다른 동반질환 암시)
서양 의학	- 흡기 시 근육의 수축에 따른 갑작스런 연구개의 폐쇄 때문에 발생하는 소리 - 잠깐의 딸꾹질: 위 팽만, 기온의 급격한 변화, 음주, 과도한 흡연, 흥분 등에 의한 - 지속적인 딸꾹질: 중추신경계의 구조적 질환 또는 감염질환, 종양, 염증에 의한 횡격막 자극, 대사장애, 혈관질환, 복강 내 질환 및 전신감염 등 고려해야 함

日) 환자가 많지는 않음. 딸꾹질이 하루종일 있다고 하고, 심한 사람들은 야간에 딸꾹질 때문에 앉아서 자기도 하는 이런 환자가 간혹 있음

2. 병인병기

- 애역의 병위는 膈(격)에 있음 - 고인들은 胃에 책임을 물음
- 주된 병기: 위실화강, 위기상역, 動膈而成 → ∴ 화강위기법 多用

① 飲食不節 음식부절

- 급하게 음식 먹거나 과식 or 한랭한 약물 or 생랭음식 지나치게 먹음
→ 한기가 중초에 쌓여 위양 손상 → 위기가 和降작용 상실하여 발생
- 辛熱 炙燔 조열한 음식 과식 → 위열 → 화로 변함 → 위기가 화 따라 상역하여 횡격막 자극

② 情志不和 정지불화

- 번뇌, 분노로 肝을 상하여 기기불리해짐 → 간기횡역 → 위 침범 → 위의 화강기능 상실
- 기울화화 → 灼津成痰하여 기체와 담탁이 상호결합해 승강이 정상적 기능 상실하여 발생

✓ 중년 여성 환자의 자살 case - by 심한 정지불화

- 50대 후반~60대 초반 여성환자가 딸꾹질이 한 달정도 되어 입원 치료함.
- 우울증, 화병 등이 있었는데 양방치료 모두 해본 후 한방치료 받으러 온 것.
- 입원 시 간호사에게 절대 환자를 혼자 두게 하지 말라고 신신당부. 일주일 정도 입원하면서 딸꾹질에 쓸 수 있는 약을 씀. 심신안정 되면 조금 줄어들다가 다시 시작됨.
- 그러다 갑자기 새벽 6시에 전화와서 갑자기 환자가 5층에서 자살하였다고 연락 음. 간호사가 잠깐 자리 비운 15초 사이에 자살. 알고보니 보호자가 남편은 아니었고, 남편과의 문제로 스트레스가 컸음.

③ 脾胃陽虛 비신양허 ex) 요독증, 간불화

- 중기를 손상하거나 허손에 잘못 공하법을 씀 → 비신의 양기가 허약해짐 → 위기 쇠패 → 청기 상승 X → 탁기 하강 X + 상역하여 횡격막을 요동시켜 발생

④ 胃陰不足 위음부족

- 열병으로 위음 손상 or 한토하법이 지나쳐 위의 진액이 손상 → 위중 음액이 부족해짐 → 濡潤작용이 실조 → 허화가 위로 타올라 위의 화강 기능이 실조하여 발생

⑤ 年老體虛 연로체허 혹은 구병모손

3. 감별진단

乾嘔	噯氣
위기가 상역하여 나오는데 소리만 나고 음식물은 나오지 않는 병증 (∴ 딸꾹소리 나와 억제 불가능한 애역과 다름)	속에서 울체된 기(gas)를 트림해내는 것으로 중기로 하여금 퍼지고 상쾌하기도 함 대개 중초기체로 흥격창만하여 발생

4. 변증요점과 치료원칙

✓ 변증요점

- 병력을 상세히 물어 병인을 파악해야 함
- 허실을 파악하고 한열을 나누어야 함
- 급중병증의 후기나 혹은 노년중허한 환자에게 발생 시 특히 주의해야 함

✓ 치료원칙 언급하신 것만 정리하였음!

① 가벼운 경우는 치료하지 않아도 낫는다 but 반복적 재발 시 검사 요함

② 陽明腑實 양명부실하여 장도불통한 경우 하법을 쓴다.

↳ 노인분들의 오심/구토에 많이 해당함.

“우리 아버님이 밥을 못 먹어서 보약을 지어주세요~” 하고 오는 보호자들 많음

but 대개 아래가 막혀 내려보내지 못하여 위로 자꾸 넘어오는 경우이므로 보약이 아닌 하법을 써야 함

5. 변증시치

[실증]

1) 위중한랭

증상	애성침완유력 / 우한즉심 / 득열즉감 / 상검흉격반위완불서 / 회음열탕 / 염식랭물 음식감소 / 구불갈 / 설태박 / 맥지완
치법	온중거한, 강역지애
처방	정향산

✓ 뇌출혈 환자의 애역 case - by 심한 정지불화

- 70대 남성 환자 뇌출혈 치료 중 딸꾹질이 생겨 일주일 이상 지속됨
- 양방에서 자율신경계 증상 치료 약을 사용했는데도 호전되지 않아 한방 내원 후 정향산, 침치료 진행하였음. 그래도 3주 정도 효과도 없이 지속됨
- 그러다가 교수님이 다른 환자에게 받은 우유를 이 뇌출혈 환자에게 주었더니 갑자기 딸꾹질이 멈춤. 그러나 다음날부터 다시 딸꾹질하기 시작함.
- 혹시나 해서 우유 한 번 더 드렸는데 증상 호전 없음. 그래서 따뜻하게 데워서 우유 먹게 했더니 나아옴
- 이후 매일 우유를 계속 먹게 되었고 증상 호전됨! (교수님은 그냥 뇌출혈 나아지면서 멈춘 것으로 봄)

2) 위화상역 ★ [기출] 애역의 변증시치 중 위화상역의 증상 치법 처방을 쓰시오.

애역의 변증시치 중 위화상역 및 양명부실의 증상 치법 처방을 설명하시오.

부저추신에 대해 설명하시오.

증상	애성홍亮 ^량 유력 / 衝逆而出 ^{출역이출} / 自發自止 / 구취변갈 / 다희랭음 / 대변비결 / 소변단적 / 설태황흑황니 / 맥활삭
치법	청화강역, 화위지애
처방	- 죽엽석고탕 가 시체 죽여 - 양명부실로 대변불통하는 경우: 소승기탕+시체+죽여 로 통리대변하고 순기강화하여 열을 아래로 배설하여 애역을 멈춘다. = 상병하취, 釜底抽薪^{부저추신}하는 방법이다. * 부저추신: 가마 밑에서 불쏘시개를 꺼내는 것을 의미. 즉, 근본적인 문제인 대장의 열을 없애는 것을 의미함!

曰) 심한 경우에 약도 주지만 관장요법(항장요법-대황망초탕을 끓여서 거르고 관장하듯이 항문에 투입을 끼워둠)을 쓰기도 한다. 전에는 많이 썼었는데 요새는 환자/의료인 다 번거로운 것을 싫어해서 거의 글리세린으로 함. 글리세린은 거의 1회성 처치이나, 대황망초탕은 재발하는 경우가 드물어서 추천하는 방법 중 하나임.

* 교수님은 대황망초탕이라 하셨는데 ppt에서는 대황감초탕이라고 하는데 뭐가 맞는지 모르겠네용..

3) 기체담조 그냥 넘어가심

증상	매유담조, 호흡불리, 흉협창만, 장명실기, 오심애기, 두목혼현, 완민식소, 설태박니
치법	이기화담, 강역지애
처방	선복화대자석탕

[허증]

1) 비신양허 간경화 말기, 요독증에서 나타남 → 자신있게 간경화, 간암, 간수치 올라간 경우 간담습열방 쓰기

증상	애성低長, 기불접속, 범토청수, 완복불서, 희열희안, 면색소화, 설질담, 태박백, 맥세약
치법	온보비신, 화위강역
처방	부자이중탕 가 정향 백두구

2) 위음부족

증상	애성단축이불연속, 순조설건, 번갈불안, 불사음식, 흑식후포창, 대변건결, 설질홍, 태소이건, 맥세삭
치법	익기양음, 화위지애
처방	익위탕

⇒ 이처럼 변증 시 대표적으로 허실로 나누고 한열로 나누고 이에 맞는 약재를 가감하여 사용

└ 한성지구약: 비파엽 선복화 죽엽 시체 등 (열증-위기상역증에 가미하여 사용 가능)

└ 허증지구약: 오수유 생강 백두구 등 가미

6. 애역의 분류 대충 넘어가심

① 상한애역: 음증, 양증

② 잡병애역: 리후애역, 식색애역, 담폐애역, 수결애역, 과실애역

7. 경과와 예후 pass

8. 예방과 조리

- 평소에 한온에 주의해 외사가 위를 범하지 않도록 주의
- 음식조절: 생령, 신열, 전작물 과식 X + 약물 주의
- 정지 서창시켜 간기형역해 비위 침범하지 않도록 해야 함
- 원발병증에 의한 경우 원발병증의 적극적 치료와 예방 조치 중요
- 자주 발생할 경우 쉽게 소화되는 음식/죽 등을 먹음

⇒ 曰) 그냥 면역력 관리 위해 생활습관 관리, 스트레스 관리, 사회적 관계 관리 해주면 됨

✓ **애역 PPT 처방**

- ① 사마윤장탕: 마자인 8g, 건지황 당귀 백작약 천궁 6g, 도인 목향 빈랑 오약 육이인 지각
진피 행인 후박 4g, 감초 홍화 2g
- ② **대황감초탕(항장요법)**: 대황 8g, 감초 4g

구토 嘔吐**1. 개요** 교과서 p. 114

정의	- 위로 들어간 음식이나 기타 위내용물이 다시 입으로 나오는 병증 - 다양한 질병에서 쉽게 나타나는 증상 - 원인을 막론하고 위기상역하면 대부분 구토가 발생 - 오심은 구토의 전구증상으로 자주 나타남
발생 질환	- 오심과 구토는 기질적/기능적 질환에서 자주 나타나는 흔한 증상 - ex. 급성 충수염, 급성 담낭염, 장폐색, 급성 복막염 등 수술이 필요한 급성복증 - 특발성 위 운동장애, 두개내압상승, 편두통 등의 중추신경계질환, 대사성 내분비질환, 각종 암 말기 및 소아의 급성 전신성 감염질환에서 주로 나타남
구토의 영향	- 구토 반복 시 식도분문이행부의 외상파열 초래하여 대량 토혈 일으킴 - 오래 계속되면 전해질상실, 탈수, 위액(특히 염산)의 상실로 저칼륨혈증을 동반한 대사성 Alkalosis 일으킴 - 혼수가 있을 경우 흡입성 폐렴 일어남 - 음식물 먹지 못하므로 전신 영양실조 초래 가능

2. 병인병기

- ① **외사범위**
- ② **음식부절**: 제일 많은 케이스
- ③ **停痰留飲** 정담유음: 비위의 운화기능 실조로 수곡이 화생 못해 담음 발생하여 중완에 쌓여 기 상역
- ④ **정지불화**: 정지불화로 간기항역하여 위 침범하여 간위불화로 위기 상역해 구토함
- ⑤ **비위허한**

㉠ 대부분 감염성 질환에서 많음 or 찬 것 갑자기 먹었을 때

✓ **정지불화 역류 환자 Case**

- 2~3년간 일주일 한 번 내원하는 역류 환자
- 원인) 강력한 스트레스. 성범죄 미수를 당하고 트라우마 우울감에 의해 역류함.
- 증상) 매 끼마다 토함. 본인의 의지와 상관없이 토함. 이제는 호전되어 컨디션 떨어질 때 한 달에 서너번 정도 밥 먹으면 바로 아무 이유 없이 바로 구토. 전조증상 없이 그냥 우웬 토하는 증상

3. 진단 및 감별진단 진단은 pass✓ **감별진단** - 반위 열격 객란

반위	- 식후 완복창민, 조식모토 모식조토, 속식불화 - 발병 완만 / 병증 오래 감 / 잘 안 나옴 - 비위가 장기가 손상받아 영양결핍하므로 환자는 형체소수, 면색소화, 신권핍력함
열격	- 주된 특징 “연하곤란” - 경증) 음식물 넘길 수 있으나 그 양이 많지 않음 - 중증) 물은 넘길 수 있으나 음식 넘기지 못함 - 위중) 물도 못 넘기고 억지로 삼키면 가슴에 막혔다가 바로 토해냄 - 병변이 위에 있는 구토와 다르게 열격은 식도와 본문에 있음
객란	- 발병 급격 / 병세 흉험 - 상토하사하고 복통하며 쌀뜨물 같은 설설ㄹ 함 - 빠르게 수척해지고 지랭하며 맥침미함 - 급성 위장병으로 대부분 감염에 의한 것임

4. 변증요점

1) **허 / 실을 가린다** [기출] 구토의 변증요점 중 실증구토와 허증구토를 구별하시오.

	실증 구토	허증구토
원인	외사, 음식, 칠정범위	비위허한, 위음부족, 실기화강
병정	발병위취 병정교단	발병완만 병정교장
치법	실증유사 거기사내유	허증무사, 위기지허소작, 온중건비 자양위음, 부정강역위주

2) **주증과 겸증을 가린다**

3) 可下證과 禁下證을 가린다

- 일반적으로 구토에 하법을 사용하지 않음: 구토의 병은 위에 있으므로 下藥으로 장을 공격하는 것은 마땅하지 않기 때문
+ 구토는 위중에 정체한 속식이나 음식물을 위로 배출하는 것이므로 하법 X
- 다만 하법을 구토에 절대 금기하는 것은 X
↳ 위장실열로 구토 발생 + 대변비결 검하고 있으면 필요에 따라 하법 사용 가능

4) 可吐와 止吐를 가린다

음주후구토 임신구토 아이들구토 노인분들 위완상역증이나 허증으로 인해서 하는 구토

5. 치료원칙 읽어보세용

[기출] 구토의 치료원칙, 약물배합, 금기증, 지구의 성약을 한열로 나누어 쓰시오

- 邪實로 인한 구토: 祛邪에 중점을 두어 사기가 제거되고 정기가 안정되길 기다림

외사범위로 인한 것	음식정적으로 인한 것	담음내조로 인한 것	간기범위로 인한 것
소사해표화위	소식도체	온화담음	조간해울 + 화위강역

- 허증에 치우친 경우: 扶邪에 중점을 둠
- 구토를 치료할 때 **약물의 배합금기**에 주의해야 함
 - 기름기 많은 약물과 비린내 나는 약물은 지구제로 사용 X
ex) 과루인 도인 아교
 - 반면 止嘔의 요약: 굴피 생강 반하 대자석

6. 변증시치 담습내조와 간기범위, 비위허한만 언급하심

[실증구토] 외사범위 음식정적 담음내조 간기범위 담열요위 언급하신 것만 정리함!

담음내조 - 원발성 구토에서 진단이 많이 되는 것.

원인	본래 비위가 허약하여 건운화수하지 못해 발생
증상	구토담연청수 / 흉완비민 / 불사음식 / 두현심계 / 흑嘔而장명유성 / 설태백니 / 맥활
치법	온화담음, 화위강역
치방	이진탕 합 영계출감탕, 온담탕

간기범위 - 급성간염, 심한 스트레스 충격에 의해 나타남

원인	간기불서로 횡역범위하여 위가 화강을 상실하여 발생
증상	구토탄산 / 애기빈작 / 흉협만통 / 번민불서 / 매우정지자극 / 즉구토탄산경심 / 태변홍 / 태박니 / 맥현
치법	소간이기, 화위강역
치방	초기에는 반하박하탕을 사용, 기울화열하면 사역산에 좌금한 합방해 사용

[허증구토] **비위허한 위음부족** [기출] 구토의 변증시치 중 허증구토의 변증시치를 쓰시오

1) 비위허한 ★ - 일차적인 원인 중 가장 많이 해당하는 변증

원인	비위허한으로 중양이 불진하여 부숙 및 운화기능 실조하여 발생
증상	음식초다즉욕구토 / 시작시지 / 위납불가 / 식입난화 / 흉완비민 / 구건이불욕다음 / 면백소화 / 권태핍력 / 희난오한 / 심즉사지불온 / 대변변당 / 설질담 / 태박백 / 맥세약
치법	온중건비, 화위강역
치방	이중환, 육군자탕

2) 위음부족

원인	열병 후 혹은 간울화화 혹은 반복구토로 위음 손상하여 발생
증상	구토반복발작이랑불다 / 흑시작건구 / 오심 / 구조인건 / 기불사식 / 완부유조잡감 / 설홍진소 / 태소 / 맥세삭
치법	양음윤조, 강역지구
치방	맥문동탕

7. 구토의 분류 종류만 읽어보라구 하심

① 허토	③ 열토	⑤ 서토	⑦ 상식토	⑨ 어혈토	⑪ 수토
② 풍토	④ 한토	⑥ 습담토	⑧ 기토	⑩ 충토	

8. 경과와 예후

✓ 경과

- 구토는 제때 치료하고 병증과 약이 부합하면 대부분 치료됨
- 발병 원인, 이환시간, 정기휴손의 정황, 치료 정확성 여부 등과 밀접한 관계 O

✓ 예후

- 초기에 정미미하한 경우 치료가 정확하면 예후 양호
- 만약 구토가 오래도록 반복발작하며 낫지 않아 기음을 손상하고 비위가 허약해지면 병정이 길어지며 회복이 어려워짐

9. 예방과 조리 읽어보세요

✓ 조리

- 소화가 잘되고 청담한 음식물을 소량씩 자주 먹는다.
- 지구약은 조금씩 자주 먹는다.

⇒ 약도 음식도 한꺼번에 먹는 것이 아니라 조금씩 자주 복용하도록 티칭해야 함

오심과 구토

1. 오심 프린트

✓ 오심의 정의

- **惡心(Nausea)**: 토해내려고 하는 표현으로 토하고 싶다는 절박한 느낌
- 불확실하고 불유쾌한 메스꺼운 감각이며 구토에 선행하여 시작하거나 또는 수반하여 발생하는 메스꺼움
- 위의 운동성은 없어지고 십이지장 일부에 지속적인 수축이 일어남
- 인두와 상복부에서 느끼는 불쾌한 느낌이며 대부분 타액과다를 동반하며 반드시 구토를 동반하지는 않음

✓ 오심의 기전

구토 전 단계로서의 오심은 구토와 마찬가지로의 기전을 갖는 것으로 생각된다. 오심의 기전에는 뚜렷하지 못한 점이 많으나 반사대에 생긴 자극이 구토 중추뿐 아니라 연수와 척수에 존재하는 자율신경중추까지도 자극시킨다. 특히 교감신경중추가 강하게 흥분할 때 오심이 발생한다. 피부 창백, 발한 증가, 타액분비 및 때로는 저혈압, 서맥 등이 동시에 일어난다.

2. 구토

✓ 구토의 정의

- **嘔吐(Vomiting)**: 소화관의 내용물을 힘 있게 입으로부터 배출하는 것(위 내용물의 강력한 배출)
 - 연수의 chemoreceptor trigger zone이 관여하는 미주신경 반사에 의해 나타나며, 식도폐쇄나 맹장에 의한 식도 내용물의 역류와는 구별됨
 - 헛구역질(retching)이나 발작적인 흥부와 복부의 움직임이 선행됨
 - 임상상: 급성위염, 간염, 분문경련, 유문경련 혹은 유문폐쇄, 췌장염, 담낭염, 식중독, 담석증, 복막염, 뇌염 등
- cf) 특히 극도로 강력한 분출물 구토 - 뇌압항진의 존재를 의미

✓ 구토의 발현기전

- 구토: 일종의 반사운동 - 대독방어반사
- 이 구심성 자극은 몸 거의 모든 부위에서 발생: 그 반사대 중 중요한 것은 인두강, 설근, 위점막
- 그 외 장관, 신장, 자궁, 눈, 심장, 관. 신우, 담낭, 담관 등이 기계적으로 혹은 독물 등에 의해 강하게 자극된 경우에 발생

- 구토: 연수의 구토중추와 화학수용체유발대에 의하여 통제
- 구토중추: 구토운동을 조정 통합하고 대뇌피질중추와 화학수용체 유발대에 의하여 구심성의 자극을 받아들임 (4가지)

- ① 소화기관의 구심성 미주신경 섬유와 장관 섬유
: 장관 또는 소화기관의 확장, 정막 또는 복막 자극 또는 감염에 의해 자극
- ② 운동과 감염에 의해 자극되어질 수 있는 전정부
- ③ 중추신경부위: 중추신경질환, 어떤 광경이나 냄새 또는 감정적인 경험 에 의해 구토유발
- ④ 화학수용체 유발대 밖의 연수에 위치하고 있으며 약과 화학요법 약물, 독성물질, 저산소증, 요독증, 산혈증, 방사선요법 등에 활성화되면 연수의 구토중추로 원심성 충격을 주어 구토함

- 구토의 원심성 경락: 횡격막신경, 척수신경, 내장 원심성 신경
- 구토 과정에서의 구토작용: 복부근육에 의하여 이루어짐
 - ① 위저부 및 식도위괄약근 이완 + 횡격막과 복벽의 강한 수축 → 복압의 상승
 - ② 복압상승 + 유문의 윤장수축 → 내용물을 식도로 밀어냄
 - ③ 흉곽내압의 상승 → 식도 내용물을 구강까지 밀어냄
 ⇒ 이 과정에 있어 정상적인 식도운동의 방향이 역방향을 이룬 것도 한 가지 구토에 대한 역할이 될 수 있다
- 구토 시 연구개 반사의 항진: 토출물의 비인강 내로의 침입 방지
- 성문의 반사적 폐쇄와 호흡의 억제: 폐 내로의 토출물 진입 방지

⇒ 기관지로 들어가지 않게 막아주는 것 중요함 (잘못하면 폐렴으로 갈 수 있음)

3. 자극양상에 따른 분류

1) 말초 자극에 의한 반사성 구토

- 반사대의 반사적 대응 때문에 일어남. 모든 장기가 고려 대상이 됨

① 위	위점막의 미주 또는 교감신경의 치를 초에 작용하는 기계적, 화학적 자극이 구토반사를 발생 ex) 자극물, 유독물, 부패한 음식물
② 위 이외의 소화기 질환	• 십이지장, 소장, 대장, 복막자극도 구토반사의 자극대임 • 충수염, 급성복막염, 담낭질환: 담관계 연축이 구토중추를 자극하여 구토가 유발
③ 인후점막의 자극	• 인두, 설근이 과민한 사람은 설압자로 혀를 누르면 간단히 구역질을 일으키며 심한 경우 구토까지 일어남. • 토하고자 할 때는 손가락을 집어넣어 혀를 누르면 토할 수 있음

	日) 인후부의 불편감과 기침 등을 호소할 때 단순히 역류성 식도염 등으로 판정할 것이 아니라 만성 편도염, 편도결석 등 편도의 문제가 아닌지에 대해 확인해봐야 함
④ 비뇨기질환	난소종양, 나팔관염
⑤ 심장	각종 심장질환, 울혈성 심부전, 심근경색, 협심증 등에 의한 발작, 디지탈리스의 대량 투여

2) 심리적 요인에 의한 구토

- 히스테리, 격심한 감정의 변화, 감각기(취각, 미각, 시각)가 받는 강한 자극
- 심인성 구토
- 음식물을 보거나 말아도 오심구토 일어나는 것 = 눈, 코의 반사대가 과민하기 때문

3) 중추성 구토

- 직접 화학적, 기계적으로 구토중추를 자극하여 구토 발생

① 화학적 자극

: 약물성 자극 / 중독성 대사산물에 의한 구토 / 세균독에 의한 구토 / 산소결핍에 의한 구토

② 기계적 자극: 뇌내압의 상승을 가져오는 질환

- 뇌종양, 뇌출혈, 지주막하출혈, 수막염, 뇌염
- 구토중추를 직접 압박하여 그 흥분성을 항진시켜 구토를 일으킴

4) 구토의 임상상

① 식사와의 시간관계	• 식후 즉각적 구토 : 정신성 구토, 위유문부 궤양, 병적인 대식증 • 식후 1시간 이상 반복 구토 : 위유문부 폐색, 위운동 장애-복벽의 연속적인 출렁임(splash) 진찰소견 보임 • 조식 전 구토: 임신, 요독증, 알콜중독, 위절제 후
② 구토에 의한 통증 소실	소화성 궤양 (cf. 궤장질환 또는 담도질환 시에는 소실되지 않음)
③ 분출상 구토	뇌압의 상승
④ 구토물의 특성	읽어보세요..

5) 특수한 양상의 구토

① 정신성 구토의 특징	• 만성적, 간헐적 • 어릴 때부터 구토의 병력 • 구토의 가족력 • 식후 즉각적인 구토의 병력 • 구역질 수반하지 않는 구토 • 억제가능 • 환자의 구토에 대한 무관심 • 정상식욕 • 입원 후 구토의 자연소실
--------------	---

② 주기성 구토	• 원인 없는 재발성 구토 • 두통, 복통, 발열 등 수반 • 갑작스러운 발현, 수일 경과 후 자연소실	• 6세 이전의 아동에서 발현 • 원인 : 정신성
③ 임신성 구토	• 첫 번 무월경 후 나타나 임신 4개월까지 존속 • Hyperemesis gravidarum: 영양결핍과 수분, 전해질 이상을 초래하는 심한 임신성 구토	

4. 합병증 [기출] 오심과 구토가 심해져서 발생할 수 있는 증상 및 합병증을 쓰시오.

Mallory-Weiss 증후군	구토 그 자체가 식도분문 이행부의 외상성파열 또는 파열을 초래하여 대량의 출혈을 가져옴
저크롬혈증 대사성 알칼리증	구토가 빈발하면 대량의 위액이 토출하기 때문에 탈수와 위액 특히 염산의 상실로 크롬혈증 이 동반하며, 혈중의 Cl가 감소하면 결과적으로 중탄산이 증가하여 metabolic alkalosis 를 일으켜 tetany 가 발생함
흡입성 폐렴	중추신경계의 억제상태에서는 위내용물이 폐로 잘못 흡입되어 흡입성 폐렴을 일으킴

5. 문진 및 감별진단

- ① 발병과 지속시간
- ② 약물과 알콜
- ③ 감염과 독소
- ④ **과거력**: 과거의 **위수술 과거력 중요!** - 구토를 유발하는 담즙성 위염
- ⑤ 구토로 보이는 환자의 진찰
- ⑥ 구토와 역류의 감별진단

오심 및 구토

1. 개요 교과서 p.267 - 거의 안 읽고 넘어가셨습니다 .. !

- ㄱ **오심**: 인두와 상복부에서 느끼는 불쾌한 느낌. 타액과다 동반 but 반드시 구토를 동반하진 X
- ㄴ **구토**: 소화관의 내용물을 강하게 입으로 배출하는 것.
 - 구역은 호흡근 및 복근의 율동성 수축으로 구토에 선행됨

⇒ 오심과 구토는 비록 임상적으로는 바람직하지 않은 부작용이나, 위장관으로부터 독성물질을 배출하고자 하는 일종의 생리적 기능임

2. 원인 및 감별진단 [기출] 오심과 구토의 원인과 감별진단을 쓰시오.

✓ 오심과 구토의 흔한 원인

감염증	유행성 바이러스 질환, 세균성 독소, 간염 바이러스
장폐쇄	선천적/후천적 유문협착증, 기능적 폐쇄, 기계적 폐쇄
중추신경계 질환	편두통, 두 개내압항진, 수막염, Meniere병, 멀미
대사성 질환	대사성 산증, 요독증, 부신부전증
약물	디지탈리스, 마약, 항암제, 알코올
정신과적 질환	대식증, 신경성 식욕부진
내장성 동통	복막염, 담낭염, 췌장염
임신	-

ㄹ 오심구토 환자 - 어린이 노인(암종 위화상역 장관과다가스) 젊은층 가임기여성

▶ **젊은 여성의 오심구토의 경우 무조건 임신여부 확인해야 함!**

✓ 21세 여자 환자의 오심구토 case - 알고보니 임신

- 21세 여성 환자 오심구토로 입원하였음. 치료 후 일주일만에 호전되어 퇴원하려 했는데 다시 악화됨
- 비화음도 써보고 여러 약 다 써봄 but 잘 안 좋아짐
- 혹시 몰라서 소변검사 했는데 임신임 ..!!
- 환자에게 알려져 다시 문진해보니 알고보니 친구의 남자친구에 의한 성범죄로 인한 임신 ...

✓ 43세 환자의 오심구토 case - 알고보니 임신

- 남편이 정관수술하여 임신가능성 없다고 신신당부한 43세 오심구토 환자.
- 치료 후 호전된 후 퇴원. 그 이후 한 달 뒤 전화와서 임신이라고 함 .. ;; 알고보니 정관수술 풀린 것.

11주차 SUMMARY

소화성 궤양

1. 개요 프린트

정의	산-펩신 등의 위액에 노출되는 식도하부, 위십이지장의 상부와 위공장 문합술 후에 위액에 직접 노출되는 소장의 부분 혹은 선천성으로 위액분비선이 있는 Mechel 게 실 등의 점막, 점막하조직 및 근육층까지 침범되는 국한된 조직의 상실 상태
호발 나이	① 보통 21~50세 사이의 청장년(특히 40세 이하)에서 대부분 발생 ② 십이지장궤양: 30세 전후로 비교적 빠름 (위산과다) ③ 위궤양: 40세 전후로 비교적 느림 (위산결핍) ④ 노년기: 위궤양 多, 궤양의 크기가 큼 + 합병증으로 출혈 多
성별 차이	- 사춘기 이후 소화성 궤양의 빈도가 증가하며 주로 남자에게 多發 - 폐경기 이후 여자의 발생빈도 증가 - 구미의 경우 성인에서 위궤양은 4배, 십이지장궤양은 10배로 남자에게 빈발한다는 보고 O
위치	위의 소만부와 십이지장의 기시부 3~4cm에 발생

ㄷ) 궤양 환자 유형

- ① 소화가 안되는 등의 증상으로 내원했는데 알고보니 궤양
- ② 궤양으로 확진 후 양약 먹다가 한약도 먹고 싶어 내원한 환자
- ③ 한방에 대해 본래 긍정적인 인식을 가진 궤양 환자

+ 미만성 암과 구분해야 함

+ 궤양의 회복

- 궤양으로 인한 통증: 6주 정도면 좋아짐 (but 통증이 없다고 궤양이 완전히 나은 것 아님)
- 궤양으로 손상된 점막의 회복: 8주 정도 걸림
- but 새로 회복된 점막은 생긴 지 얼마 되지 않아 약하므로 6개월 정도는 금연, 술 자제시킴
- * 담배연기는 소화기 내부로도 들어가므로 흡연은 높은 재발의 요인!

2. 점막의 침범 깊이에 따른 분류

UI 0/1 기	UI 2기
미란, 점막하층 침범한 경우	점막하층까지 침범한 경우
UI 3기	UI 4기
고유근육층까지 침범하지만 관통하지 않는 경우	고유근육층을 통과한 경우

미란과 궤양

ㄱ 궤양: 점막하층을 초과하여 조직이 결손되는 상태

ㄴ 미란: 점막하층을 초과하지 않는 결손상태

궤양이 다발하는 부위: 분문, 유문, 전정부

3. 원인 [기출] 소화성 궤양의 발생 원인 및 병태생리에 대해 쓰시오.

1) 원인 및 병인

- 산-pepsin설 / 방어인자와 분비억제인자설 / 위염설 / 유전설 / 혈관-자율신경설
- 내분비관계설 / H.pylori설 등
- Shay의 성인론

[기출] shay의 성인론에 따르면 공격인자와 방어인자간의 균형과 파괴가 소화성궤양을 유발한다고 하였다.

공격인자와 방어인자에 대해 서술하시오.

산 및 pepsin의 점막에 대한 공격인자와 그 장애작용으로부터 점막을 방어하는 기구로서의 방어인자와의 평행이 파괴되어 공격인자가 상대적으로 우위의 상태가 되었을 때 궤양이 발생

▶ 공격인자와 점막 방어인자

공격인자		방어인자 Prostaglandin	
HCL	• 위점막: HCL에 대해 강함 • 십이지장: HCL에 영향받기 쉬움	점액, 알칼리 분비	① 점막세포를 덮고 있는 점액 : 산, 소화효소, 외래 자극물질과의 접촉 방지 ② 알칼리: 산중화 → 점막보호
펩신	펩신의 단백분해작용이 점막을 공격	세포재생	
점막손상물질 ex) 알코올, 카페인, NSAIDs, 활성산소 등		점막혈류	
H.pylori		십이지장의 억제	

▶ 균형의 파괴와 위궤양 / 십이지장궤양의 발생

- └ 공격인자의 증강 = 십이지장 궤양으로 진행
- └ 방어인자의 증강 = 위궤양으로 진행
- └ 기타 위산과다 = 십이지장 궤양으로 진행

2) 급/만성 소화성 궤양을 발생시키는 원인

급성 소화성 궤양	① 질환: 두개강내 출혈 등 중추신경계 질환 / 화상 / 심한 감염증 / 심근경색증 ② 외부 손상: 수술 / Shock ③ 약물: 아스피린 등의 약물로 인해 상부소화관의 급성 다발성 궤양 유발
만성 소화성 궤양	정신적 stress / 흡연, 음주 / 방향성or자극성 음식물이나 약물 / 불규칙한 식사 식사의 불충분 / 스테로이드제 복용 등

✓ 지인 소개로 온 환자 Case

- 취업의 불안감 + 원인불명의 하지통증(야간에 왼쪽만 더 심해짐)
 - 평소 체력도 좋고 운동도 열심히 하나 식사를 잘 하진 않음 - but 건강보조식품 8개나 먹음!!
 - 교수님은 건강염려증에서 좀 더 지난 ver,으로 봄 (우울증의 초기 단계일수도)
 - 치료로 건강보조식품 먹지 말라고 했는데, 그 이후로 안 옴
 - 아마 보조식품 의존도가 높는데 먹지 말라하고 + 병원에 사람 별로 없는 등 여러 요인으로 ..
- 다음부터 내원 안함 π.π

4. 위액과 소화성 궤양

1) 위액분비

하루에 분비되는 위액량	정상 성인 공복 시 분비량 평균 1000~1500ml + 산농도 40mEq/L
위액의 성분	염산 / 점액 / 단백소화효소 / 노효소 / carbonic anhydrase / lysozyme / lipase와 기타 효소로 구성 └ 위벽세포에서 분비되는 성분) 능동적으로 분비되는 고동도의 염산 및 염화카리를 포함 └ 비벽세포에서 분비되는 성분) 간질액과 거의 같은 것
위액의 분비 속도	점막의 혈류량과 비례하고, 그 혈류량 외에도 histamine이나 gastrin에 의해 산의 분비가 촉진됨

식사습관 중 **다작**은 위액분비가 되는 충분한 시간을 주므로 중요한 습관 중 하나임!

▶ 공복기 위액량 및 위산농도의 비교

	정상인	십이지장 궤양	위궤양	위암
위액량	1000~1500ml	3000ml	정상인과 비슷	정상인과 비슷
위산의 농도	40mEq/L	40~80mEq/L	저하됨	가장 저하됨

2) 위산분비 조절 by 뇌상 / 위상(기전 2개) / 장상

[기출] 위산 분비 기전에 대해 쓰시오.

① 뇌상	음식을 보거나 냄새를 맡거나 음식 맛을 보게 되면 시작됨 = 즉 by 생각
② 위상	└ (1) 직접 위저부 확장 → 국소적 cholinergic 반사를 활동화 → 위산 증가 └ (2) 간접적으로 위유문부가 염기에 의해 자극되거나 팽창될 때 국소적 cholinergic 반사에 의해 gastrin 분비가 증가됨
③ 장상	여러 가지 음식물 특히 peptone 등이 소장에 들어올 때 체액물질의 중계에 의해 위액분비가 자극받는 것 └, but 소장의 주 기능은 위액분비 증가보다는 그 억제 에 더 큰 의미가 있음

▶ gastrin의 기능

- | | |
|------------------------|------------------|
| ① 위산/펩신의 분비 촉진 | ④ 간에서의 담즙 배출량 증가 |
| ② 위 및 장의 운동 향진 | ⑤ 식도하부괄약근의 긴장 감소 |
| ③ 췌장 분비액의 양 및 효소함량의 증가 | ⑥ 내인자의 증가 등 |

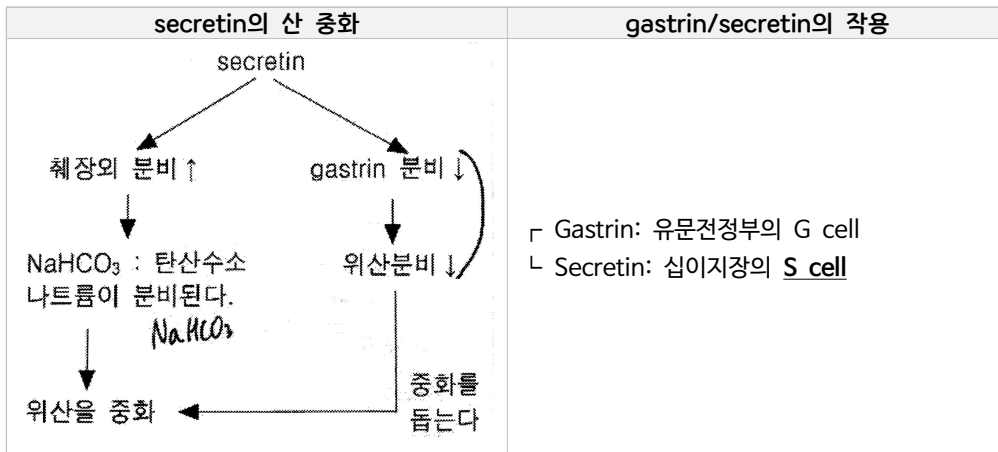
▶ gastrin 분비를 항진시키는 것

① 위 내용물	ethanol이나 glycine 등 aminoacide에 의해 혈중 gastrin ↑
② acetylcholine (Ach)	미주신경 특히 gastin branch의 자극을 받아 분비 항진
③ 고칼슘혈증	부갑상선 기능항진증

▶ gastrin 분비를 억제시키는 것

① 위산	음식물이 위 속에 들어오면 gastrin이 분비됨 + parietal cell에서 HCL 분비 • 음식물이 어느 정도 산성이 되면 gastrin이 잘 나오지 않게 됨 • pH가 2.0 이하가 되면 gastrin이 전혀 분비되지 않음
② secretin	위에서 십이지장으로 음식물 들어오면 secretin이 분비됨 ↳ secretin: 췌장에서 알칼리성 췌장액 분비를 촉진 + 강산성 음식 중화시킴 + 동시에 secretin은 gastrin의 분비와 위산의 분비를 억제하며 소장 내의 산이 중화되는 것을 도움

▶ secretin의 산 중화와 gastrin/secretin의 작용



3) 위액분비의 억제기전 그냥 넘어가심

- ① 위내 산농도 증가해 pH 1.5 이하가 되면 위유문전정부의 점막을 직접 자극해 억제 호르몬 분비 하거나 gastrin의 형성/분비 억제시킴
- ② 소장상부에 지방/담즙/췌장의 지방분해산소 등이 같이 있으면 억제 호르몬인 secretin의 분비가 촉진됨
- ③ 십이지장에 산성 내용물이 들어가면 적어도 일부는 호르몬의 영향으로 위액분비 감소
- ④ 특정 정서상태에서 미주신경 or 내장신경 중 억제신경 or 반사작용에 의한 혈관수축에 의해 위액 분비 감소함

▶ 조직의 저항력

: 산 혹은 점막을 손상할 수 있는 여러 가지 영향에 대한 위/십이지장의 저항력

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| ① 점막세포의 통합성 | ④ 충분한 혈액순환 |
| ② 빠르고 지속적인 상피세포의 재생능력 | ⑤ 위/십이지장 점막의 투과력 |
| ③ 점막 방어벽 | |
| ⑥ 위/십이지장계양에서의 방어인자 및 위액의 분비억제인자 | |

ㄹ) 위장관 평활근의 위액 분비에 중요한 것은 "혈액순환"

- 위액 또한 혈액의 일부이므로 혈액을 잘 작용할 수 있게 해주는 혈액이 중요한 요소
- 소장육부 사지말단의 혈액순환이 잘 이루어지도록 하려면 피를 맑게 해줘야 함 = 精血
- 단순히 농도를 희리게 하는 것이 아니라 혈액의 기능을 어떻게 잘 높일 것인가가 중요함

5. 소화성 궤양의 병리적 형태

[기출] 소화성 궤양의 발생 원인 및 병태생리에 대해 쓰시오.

- ① 출혈성 미란
- ② 급성 소화성 궤양
- ③ 아급성 소화성 궤양
- ④ 만성 소화성 궤양: 95%가 소만곡의 후벽 끝부분에서 생김 → 유문에서 5-10cm 사이에 위치함 (소수의 궤양은 유문강내 or 식도근처의 분문에 발생)

6. 급만성 궤양과 궤양의 경과

1) 급성궤양과 만성궤양의 비교

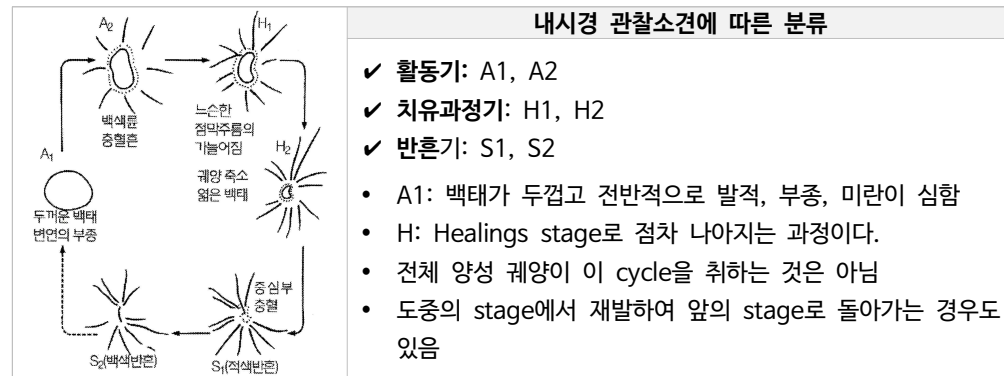
	급성 궤양	만성 궤양
onset	급격	완만
유발인자	확실한 것이 많음	확실하지 않음
궤양의 깊이	얕다	깊다
궤양의 개수	다발성	단발성
치료	잘 반응한다	저항성이 있다
재발	없다	중중
stress의 영향	크다	적다
별칭	Stress ulcer	Peptic ulcer

▶ 급성 위점막 병변

- 급격한 위증상을 동반하고 내시경에 의해 위점막에 이상 소견이 나타나는 병변
- 한국성 또는 미만성의 급성 미란성 위염
- 단발 및 미만성의 급성 위궤양
- 출혈성 위염을 말하며 이들 병변이 서로 섞여 있음

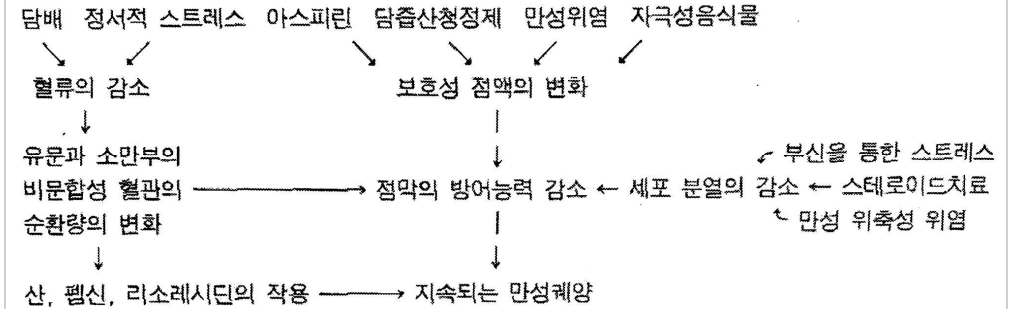
2) 궤양의 경과 Stage

[기출] 소화성 궤양의 내시경적 관찰소견에 따른 경과에 대해 설명하시오.



ㄹ) 각 stage의 상세 내용은 사진으로 확인하는 것이 낫다고 하시고 상세 설명은 안하심!

3) 특정 위치의 만성화 기전



ㄹ) 만성질환 기능성질환은 치료도 중요하나 **생활습관**이 더 중요하다.

기전을 보면 담배나 stress와 같이 생활과 연관된 요소가 원인이 되므로 생활습관 관리해야 함

* **세포분열의 감소** = 점막 재생이 잘 안되는 것

↳ 궤양을 없애고 염증을 없애는 기본적 방법 = 세포점막의 재생시키기

↳ **세포점막 재생에 좋은 약재**: 황기, 작약, 유근백피

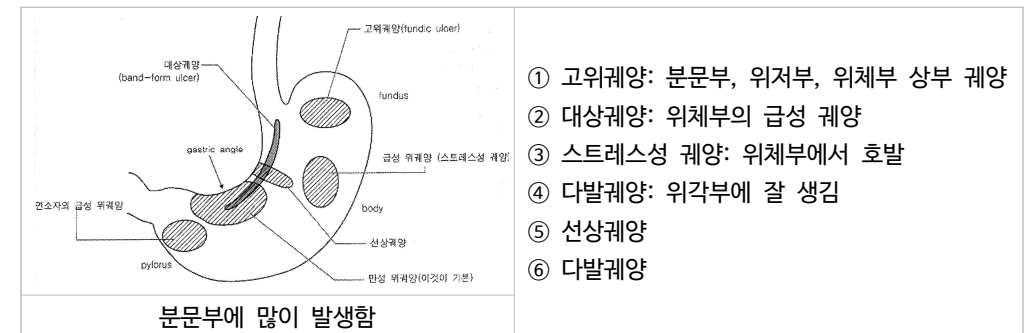
↳ **통증이 있을 경우 좋은 약재**: 작약, 현호색, 오적골, 패모

↳ 증상의 양상에 따라 처방을 해야 함 + 원인이 뚜렷하다면 원인 치료가 우선!

7. 궤양의 구분

1) 위궤양

- 일반적으로 위궤양은 만성 위궤양을 뜻함
- 위체부에 호발되는 급성 위궤양은 스트레스의 영향을 많이 받은 급성 위점막 병변에 속함
- 십이지장 궤양에 비해 고령자에 많으며 위산은 정상이거나 항진된 경우 다
- 만성 위궤양의 호발부위: 위각 (→ 위각 외의 궤양은 장소와 궤양의 형상에 따라 명칭 다름)



2) 십이지장 궤양

- 공격인자의 증강 = 위산과다로 생기는 궤양
- H.pylori 감염률이 거의 100%임
- 호발부위: duodenal bulb의 ant.wall (→ post.wall 뒤에 궤창 있어 궤양은 penetration 되기 쉬움)
- 젊은 층에 다발
- 3대 합병증: 출혈 / 유문협착 / 천공 등 (부위에 따라 예후가 달라짐)
 - ↳ 반복적으로 유문이 협착되면 유착이 일어날 수도 있음 + 천공도 간혹 잘 일어남
 - ↳ 수술 후 유착은 많은 문제를 일으킬 수 있는 요소이므로, 문진 시 반드시 치료 기왕력을 물어봐야 함
- 유문괄약근 or 십이지장의 첫 수 cm 부위(=유문주위)에 발생한 궤양은 위궤양과 동일 형태
- 급성궤양은 다발성이며, 만성궤양은 대부분이 하나이며 십이지장의 전후벽에 생김
- 때때로 양쪽 벽에 하나씩 있는 두 개의 “입맞춤 궤양(kissing ulcer)”이 있음

3) 난치성 궤양

- 적절한 내과적 치료를 했음에도 불구하고 일정기간(3-6개월) 이상 경과해도 치유되지 않는 궤양
- 치유된 다음에도 재발 재연이 반복 + 중도 악화가 잦음 + 유병기간이 길다

그냥 넘어가신 아래 부분은 간단히 표로만 정리해드립니다!

4) 그외

4) 재발성 궤양	점막 집중을 나타내는 궤양반흔 위에 또는 근접하여 생긴다.
5) 거대 대상 참호형 궤양	급성궤양의 하나로 위체부에 호발하고 종축으로 길고 넓게 띠 모양으로 생기며, 전후벽에 대칭적이며 약간의 출혈이 동반됨
6) Mallory-Weiss 증후군	분문부 근처 점막에 열창이 생겨 소화관 출혈이 생기는 증후군 - 원인: 구토 등에 의해 복강 내압이 급격히 상승하는 경우 - 음주, 심한 기침 등에 의해 발병 - 치료: 보존적 치료, 대부분 자연지혈 됨 (내시경적 지혈)

▶ 특발성 식도파열과 Mallory-Weiss 증후군의 차이점

	특발성 식도파열	Mallory-Weiss
원인	급격한 식도내압의 상승	급격한 식도 내압의 상승
laceration의 깊이	전층	점막 하층까지
주된 증상	흉통	토혈
치료	긴급 수술	보존적 치료

8. 소화성 궤양이 나타나는 합병되는 질환

- ① 위산이 저하된 위암의 경우에 궤양 동반될 수 있음
- ② 체내에 탄산 gas가 축적될 수 있는 질환의 경우 특히 십이지장궤양 빈발
- ③ Rheumatoid arthritis 환자의 20%에서 소화성 궤양 有
- ④ 두개강내출혈 등의 중추신경계 질환이나 화상, 심한 감염증, 심근경색증, 수술, shock 등이 있으면 상부 소화관의 급성 다발성 소화성 궤양 유발

9. 증상과 진단

1) 증상

- ① 동통 및 속쓰림^{#1} (제일 多)
- ② 신트림 및 헛배부름
- ③ 구역 및 구토
- ④ 식욕^{#2}
- ⑤ 출혈

#1 동통 및 속쓰림

- ↳ 상복부의 공복통 및 식후통 - 위궤양(식후통) / 십이지장궤양(공복통, 야간통)
- ↳ 무통성일 수도 있음
- ↳ 방사통: 십이지장에서 배부로
- ↳ 식후 혹은 알칼리 섭취로써 동통이 완화됨

#2 식욕

- 십이지장 궤양에서는 증진될 수도 있고, 위궤양에서는 감퇴될 수도 있음

▶ 식사시간과 궤양과의 관계

- ① 식도궤양: 식사 도중이나 식사 직후에 나타나는 동통
- ② 위궤양: 대개 식사 후 30-60분에 나타난다
- ③ 십이지장 궤양: 대개 식사 후 2-3시간 후에 나타난다

2) 진단 : 거의 내시경으로 확진하게 됨

10. 소화성 궤양의 치료 [기출] 소화성 궤양의 치료법을 쓰시오

- 내과적 치료목적: 증상의 완화, 궤양의 치유 및 합병증과 재발 방지
- 생리학적 면: 염산/펩신의 작용으로부터 위점막을 보호하고 조직의 저항력을 증강시켜줌
- 전신 건강을 유지하고 식사나 음료 및 약물 중에서 위장관을 자극하는 것을 피하고 정서적 안정을 취하는 것 등이 도움됨

ㄱ) 궤양의 치료는 보통 4~6주가 걸린다. 초기 증상이 없어질 때까지 치료를 하며, 이후 6개월 정도는 생활습관과 식이조절을 하게 해야 함

1) 안정과 휴식	• 정신적 긴장은 위산분비를 증가시키고 위십이지장 점막의 궤양화를 촉진시키므로 안정과 긴장해소가 중요 • 재발된 경우에는 신체적 과로가 겹치는 경우가 많으므로 격심한 육체적 활동 피해야 함
2) 식이요법	• 음식물은 위산을 중화/완충시킬 수 있으므로 매 2~3시간의 규칙적인 식사 (1일 6~8회로 소식다차) • 맛있는 음식을 먹어야 함 + 규칙적인 식이습관 • 정상영양을 유지할 수 있는 충분한 식사 섭취 • 식사시간 동안에 신체/정서적 안정 필요함 • 담배, 알코올, 커피, 자극성 식사 및 약제 등은 위액 분비를 촉진시키고 점막을 자극하므로 금하여야 함
3) 양방적 치료	① 공격인자의 제거: H.pylori의 박멸 / 위산분비 억제 / 항펩신제 복용 / 알콜이나 NSAIDs 등 위점막에 장애를 주는 물질 섭취 X ② 방어인자의 증강: 점막보호제 / 점막 피복제 / 점액생성 촉진제 / 점막 미소순환개선제 / 프로스타글란딘의 합성촉진제 ▶ 외과적 치료의 적응증 • 심한 위장관 출혈 • 궤양부위 천공에 의한 복막염 • 유문부 협착증 • 치료가 잘 안되거나 재발이 잦은 경우 • 악성 병변의 우려가 있는 경우

11. 소화성 궤양의 한방적 치료 [기출] 소화성 궤양의 통치방과 변증시치를 쓰시오

1) 治療方 치료방

통치방	단삼보혈탕 / 가미보위탕 / 오패산 / 안중산 / 봉밀탕 / 감초말 / 이진탕 가미보양탕 / 화담청화탕
토혈	서각지황탕가미복령 / 이중탕가미천궁갈근 / 대소음자 / 연심산 / 측백산 시제백출산
변혈	황토탕 / 적소두당귀산 / 평위지유탕 / 괴화산 / 박하전
보혈	양혈사물탕 / 당귀보혈탕
정신적 안정	귀비탕에 가감
위통이 심한 경우	가미강부탕
위산과다인 경우	평위산에 황련, 용골, 모려, 석결명

2) 변증시치 - 기체 / 허한 / 위음허 / 울열 / 어혈 / 담결

변증시치 6가지에서 쓰는 처방과 가미되는 약들, 처방 이름 등 잘 알아두기!

[기출] 소화성 궤양의 변증시치 중 변증과 처방을 설명하시오

① 기체증 ㄱ) 처방에 들어가는 약물들 유심히 보기

증상	위완동통 / 량협창민 / 애기시작 / 선태식 / 정서불안 / 반산조잡 / 설태박백 / 맥현
치법	소간화위 / 이기지통
처방	사역산, 시호소간산, 선복화대자석탕, 소요산합금령자산

	시호	향부자	작약	현호색	지각	반하	생강	인삼	감초	백출	복령	금령자	기타약물
사역산	○		○		○				○				
시호소간산	○	○	○		○				○				천궁 진피
선복화대자석탕						○	○	○	○				선복화 대자석 대조
소요산합금령자산	○		○	○			○		○	○	○	○	당귀 박하 맥문동

② 허한증

증상	위통구발 / 면면작통 / 다좌음전축야간통 / 우랭죽가증 / 희난희안 / 면색위황 신평피력 / 변당 / 뇨청 / 사지불온 / 설담태박백 / 맥완혹침세무력														
치법	온중산한 / 건비화위														
처방	향사육군자탕 합 량부환가감 ^① , 이중환 합 황기건중탕가감 ^② , 황기건중탕가감 ^③														
	인삼	황기	백작	계지	감초	생강	건강	량강	목향	사인	향부 자	백출	진피	복령	기타약물 익지인, 백두구, 반하 대조, 이당
①	○		○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	
②	○	○	○	○	○		○		○			○	○	○	
③	○	○	○	○	○	○	○	○			○				

③ 위음허증

증상	위완은작통 / 공복시증 / 조잡 / 배가 고프는 것 같으나 먹으려 하지 않음 / 구건설조 대변건결 / 수족심열 / 설홍소진유극문 / 소태혹화박													
치법	양위음 / 청허열													
처방	일관전가감, 양위탕가감													
	맥문동	옥중	백작약	석곡	사삼	죽여	당귀	기타약물						
일관전가감	○		○	○	○	○	○	지모, 초치자, 생지황, 구기자, 천속자						
양위탕가감	○	○	○		○			진피, 백두구, 생곡아						

ㄹ 위음허의 약물들은 다 외워두자

④ 울열증

증상	상복동통 / 통무정시 / 식입동통불완 / 위중작열 / 반산조잡 / 심번이노 / 구건인건 갈희랭음 / 변비소적 / 설홍태황 / 맥현삭													
치법	양음유간 / 화위설열													
처방	일관전합좌금환, 화간전가감, 량격산, 양위산, 단치소요산, 진평탕가감													

구성약물	黃連	梔子	牡丹皮	白芍	黃芩	茯苓	薄荷	陳皮	沙參	麥門冬	地黃	當歸	大黃	芒硝	甘草	知母	기타약물
처방명	連子																
一貫煎合左金丸	○			○					○	○	○	○					
化肝煎加減	○	○	○	○				○		○						○	
涼膈散		○			○		○						○	○	○		
清胃散	○		○								○	○					
丹梔逍遙散		○	○			○	○			○		○			○		
陳平湯加減		○			○	○									○		
金鈴子, 吳茱萸																	金鈴子, 吳茱萸
青皮, 夏枯草, 石斛																	
連翹, 竹葉																	
升麻																	
柴胡, 白朮																	蒼朮, 厚朴, 蒲公英, 香附子, 枳殼
蒼朮, 厚朴, 蒲公英, 香附子, 枳殼																	

⑤ 어혈증

증상	동통교중이특구 / 어처불이 / 식후통심 / 안압경통 / 통철홍배 / 반복토혈 / 변혈 설질압자혹어반 / 맥현혹지삽													
치법	화어지혈, 이기화위													
처방	격하촉어탕가감, 단삼음합실소산가감, 격하촉어탕합실소산													

구성약물	桃仁	紅花	當歸	川芎	赤芍	牡丹皮	五靈脂	玄胡索	香附子	川練子	生蒲黃	丹參	기타약물	
처방명	仁	花	歸	芎	芍	皮	脂	索	子	練	黃	參		
膈下逐瘀湯加減	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			鬱金, 枳殼, 烏藥, 甘草	
丹參飲合失笑散加減			○		○		○	○			○	○	木香, 甘草, 檀香, 砂仁, 白芍	
膈下逐瘀湯合失笑散	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		甘草, 烏藥, 枳殼	

장상피화생, 위축성 위염 환자의 경우 어혈증이 많음 - 어혈증에 사용되는 약물 잘 봐두기!

⑥ 담결증

증상	상복창통 / 식후경극 / 심하건만 / 토기범산 / 납매 / 구건 / 구토숙식 / 토후통감 복중록록유성 / 태백니혹후니 / 맥현활혹유약													
치법	온중화음, 건비리습													
처방	계지출백탕 합 반하후박탕가감													

구성약물	茯苓	桂枝	厚朴	乾薑	蒼朮	白朮	半夏	紫蘇	陳皮	甘草				
처방명	苓	枝	朴	薑	朮	朮	夏	蘇	皮	草				
苓桂朮甘湯合半夏厚朴湯加減	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				

3) 약물의 가감법 그냥 넘어가심

- (1) 증에 따른 가감법
- (2) 효능 및 약성별 가감법
- (3) 침자요법

12. 경과 및 예후

- ① 급성궤양: 정신적 안정, 휴식, 식이요법 및 치료를 병행하면 비교적 단기간(2~3주 내)에 치료
- ② 만성궤양: 통상 8~10주의 치료를 요함
- ③ 궤양의 재발률: 1년 내 10~50%, 5년 내 50~80% (by 과로, 감정불안, 식사부조리, 감염 등)
- ④ 생명에 대한 예후는 합병증이 발병하지 않는 한 양호함 - but 암으로의 발전 주의!

13. 소화성 궤양의 합병증 [기출] 소화성 궤양의 합병증을 쓰시오**1) 협착증** - 가장 흔함

- 유문부 주위나 십이지장에 궤양이 있을 때에 내강이 자주 좁아지거나 위배출을 지연시켜 증상을 나타내는 경우가 흔히 많음
- 폐색증은 이러한 협착증으로 인해 정상적으로 음식물이 소장으로 이행되지 못할 때 유발됨

원인	① 활동성 궤양이 있는 주위조직의 염증성 부종 ② 유문부 or 십이지장구 주위의 반량 ③ 위전정부의 궤양과 염증으로 인한 협소 ④ 만성 위궤양으로 인한 소만곡의 단축으로 위전정부가 상부쪽으로 수축되고 유문부의 뒤틀림이 있음
증상	• 구토(주증상): 1~2일 전에 먹었던 시큼한 냄새나는 음식을 토함 • 식후 팽만감, 식욕부진, 체중감소, 활동성 궤양으로 인한 동통 등
치료	소화성 궤양 치료에 준함

2) 출혈 - 소화성 환자의 25%

- 궤양의 기저부에 생긴 육아조직이 동/정맥/모세혈관을 관통해 증식하여 발생
- 후벽에 위치한 궤양에서 다발
- 십이지장 궤양에서보다 위, 십이지장구 후에서 더 흔히 발생하며 더 심한 경향 O
- 50세 이상에서 더 자주 오나, 심한 출혈은 오히려 젊은 연령층에서 잘 생기는 편

원인	신경성 긴장, 무분별한 식사, 과도흡연, 자극성 약물, 음주 등과 관련
----	---

증상	토혈, 흑색변
치료	• 경하거나 중증도의 출혈 or 대부분의 대량출혈 초기에는 내과적 치료 • 환자의 절대 안정, 환자의 두부 낮추고 빈번한 유동식의 토여 • 매 시간 제산제, 지혈제, 항궤양제 투여

3) 천공 - 모든 궤양의 약 1~2%

- 고연령, 남자, 겨울, 식후의 오후 늦게 가장 많이 일어남
- 심한 신경성 과로, 구토, 기침, 배변 시의 긴장, 복부의 타격 등에 의해 유발
- onset이 급격한 통증 / 복벽경직, Blumberg's sign / 간막음 소실 / 입 위 단순흉부 X선 - 흉격막 아래에 free air / 고아밀라아제혈증

증상	• 상복부의 갑작스럽고 격심한 복통으로 시작하여 빠르게 전복부로 퍼짐 • 환자는 쇠약해지며 안색이 창백해지고 불안해함 • 몸의 운동으로 인해 동통 심해져 누워 있으며 호흡은 짧고 가쁨 등 (print 참고)
치료	반드시 외과적 치료 필요

▶ 치양탕

: 백작약 감초 오약 백출 사삼 소회향 황기 해표초 향부자 현호색 목향 몰약 진피 후박 곽향 소엽

소화성 궤양

1. 궤양 발생의 원인 및 병태생리 교과서

[기출] 소화성 궤양의 발생 원인 및 병태생리에 대해 쓰시오.

- | | |
|--|--------------|
| ① 소화성 궤양과 위염 | ③ 산과 펩신 |
| ② 소화성 궤양과 H.pylori의 감염 | ④ 펩신과 소화성 궤양 |
| ⑤ 위, 십이지장 운동성의 장애 | |
| - 유동성 음식물이 위에서 너무 빨리 배출되어 음식물에 의한 산의 중화효과가 떨어져 십이지장이 과다한 산에 노출되어 궤양의 위험성이 높아진 환자 O | |
| - 위궤양 환자에서 관찰되는 음식물 특히 고형식의 위내저류, 전정부 운동능의 감퇴, 십이지장 내용물의 위내역류 등은 H.pylori나 비스테로이드성 항염증제에 의한 위점막 손상을 더욱 악화시키는 2차인자로 생각됨 | |
| ⑥ 비정상적인 점막 방어능 상태 | |
| ⑦ 비스테로이드성 항염증제와 소화성 궤양 | |
| ⑧ 음식 및 기호식의 관련성: 흡연 | |
| ⑨ 유전적 소인 | ⑩ 정신적 소인 |

병태생리 10가지는 반드시 알아두자!

썸부) 여기까지만 언급하시고 나머지는 프린트에 있는 내용이니 넘어간다고 하셨습니다!

12주차 SUMMARY

열격 噎膈

1. 개요 교과서 p127

[기출] 열격의 서양의학적 병명을 쓰시오

정의	- 음식을 삼킬 때 장애를 받아서 “食入即吐” 하는 병증 - 噎: 삼킬 때 목이 메어 순조롭지 못한 것 (단독으로 나타나거나 膈의 전구증상) - 膈: 가슴이 막혀서 음식이 내려가지 않는 것
원인	대개 우사울노, 음식소상, 한온실의, 방로상신으로 인해 장기가 불화하고 기혈이 어결하며 음액이 枯槁(고고)하여 흉격을 填塞(전새)하므로 음식을 넘기기 어려운 것
증상	- 초기: 목구멍or식도 내의 이물감 O / 음식 먹을 때의 정체감 / 위완불속, 소작통, 식시통심 등이 나타남 - 계속 진행하면 삼킬 때 흉격동통하고 식입즉토하며, 심하면 白沫(백말)이나 적두즙 같은 것을 토해내고 대변이 조절하여 羊屎(양시)와 같다
서양 의학적 분석	기계적 연하곤란을 유발하는 식도의 악성 종양 및 협착 / 하부식도질환과 식도이완 불능증 / 미만성 식도경련 / 식도의 경피증 / 인두마비 / 윤상인두근 무이완증 등의 운동성 연하곤란증이 열격의 범주에 속함

2. 병인병기

1) 憂思鬱怒	- 憂思는 비를 상함 → 기결 → 진액이 담 형성 → 기와 담이 엉기어 상역하고 하강하지 못함 → 음식이 담연을 따라 위로 나옴 - 鬱怒하여 傷肝 → 비에서 담 형성 → 음식을 먹지 못하게 됨
2) 飲食所傷	음식의 부절제로 비위를 손상하면 열격을 형성함
3) 寒溫失宜	한열의 사기를 감수하면 비위를 손상하여 열격을 발생할 수 있음
4) 房勞傷腎	방로가 과도하여 정혈이 소모되면 모든 장부에 영향을 미침 = 환자의 면역력 문제와 연관된 것

3. 진단과 감별진단

1) 진단

- 중년 이상의 남성으로 평소에 嗜酒^{기주}하고 비감한 음식을 恣食^{자식}하며 정지가 억울한 사람 多
- [개요의 증상]과 동일한 내용의 증상을 보임
- 몸은 수척해지고 피부는 꺼칠해지며 정신이 고달파짐
- 설질은 홍강하거나 청자하며 태는 적다. / 맥은 현세삭하거나 삽함

2) 감별진단

[기출] 매핵기의 정의, 원인, 증상, 치법, 처방을 쓰시오

매핵기 ¹⁾	• 목구멍에 어떤 것이 걸린 듯한 자각증상이 있으나 토해도 나오지 않으며 삼켜도 내려가지 않음 • 음식의 섭취에는 방해가 없어 열격과 감별 가능
반위	• 음식이 내려가서 소화되지 않고 위중에서 머물렀다가 “밤에 먹으면 낮에 토하고, 낮에 먹으면 밤에 토함”의 증후가 나타남 • but 열격은 막혀서 불통하여 음식이 내려가지 않는 것으로 감별 가능
구토	• 기가 위로 상역하여 발생 → 연하곤란 X (열격은 음식이 막혀 내려가지 않음)
애역	• 기기의 상역으로 말미암아 喉間에서 딸꾹 소리가 연이어 나며 소리가 짧고 잦으며 스스로 억제할 수 없는 것
관격	• 소변불통과 구토불지가 같이 나타나거나 구토 증상에 점차 大소변불통이 나타나는 병증 = 만성 신부전 환자들에게 많이 나타남

1) 매핵기: 보통 역류성 식도염으로 진단받고 온 환자를 진찰하면 만성 편도선염일 가능성이 높음
만성 편도선염 환자의 경우에도 연하곤란이 있으나, 설압자로 편도 확인 시 편도가 부어있거나 편도결석을 관찰할 수 있다.

4. 변증요점와 치료원칙 日) 읽어보세요!

변증요점	① 유형을 분명하게 가려야 함 ② 허실을 구별하여야 함 ③ 표본완급을 명확하게 나누어야 함
치료원칙	• 초기, 중기: 실증이 많으므로 개울화기, 화담산결 위주 + 자음윤조 겸함 • 말기: 비신양허하고 정휴액고하므로 온보비신과 양혈자음 + 연건산결

5. 변증시치 넘어가심

- ① 痰氣交阻^{담기교조} ② 津虧熱結^{진휴열결} ③ 痰瘀內結^{담어내결} ④ 氣虛陽微^{기허양미}

日) 전체적인 변증은 가능하지만, 보통 증상에 대한 대증치료를 진행하므로 간단히 한 번 읽어보셈

✓ 식도암 환자 Case

- 10년 전쯤 간경화 진단을 받고 본 병원에서 간담습열방 복용 후 간수치 매우 좋아짐
- 이후 식도암이 걸려 다시 내원함 (위의 경협으로 양방으로 안 가고 한방으로 옴)
- 그러나 이미 발견했을 당시 방사선 치료를 하지도 못할 정도로 많이 전이된 상태임
- 고형물 먹지 못하고 미음만 삼킬 수 있는 상태 + 사실 해줄 수 있는게 많이 없어 안타까움
- 식도암은 위처럼 음식을 잘 먹지 못하므로 예후가 좋지 않음

6. 열격의 분류

[기출] 열격의 변증시치 중 기격의 원인, 증상, 치법, 처방을 쓰시오

六噎	五膈
칠정열 / 담열 / 식적열 / 허열 한열 / 삼양열	기격 / 담격 / 식격 / 한격 / 열격

+ 삼초열격 (읽어보세요 하고 넘어감)

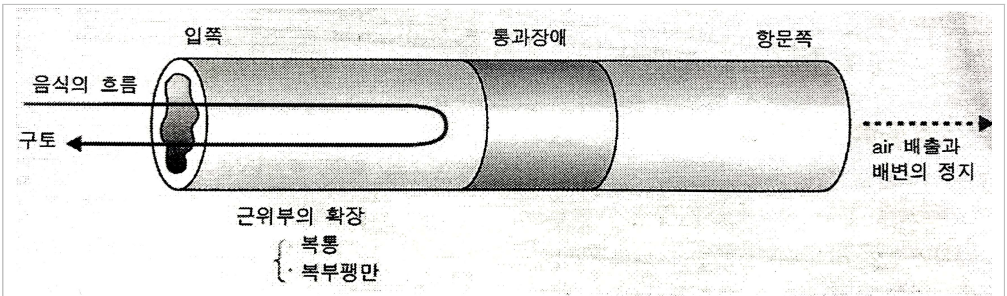
7. 경과와 예후

- 膈은 흔히 噎로 말미암아 생김
- 초기에 정기가 대허하지 않은 경우는 다만 연하가 어렵거나 혹은 식후에 가슴이 답답하고 뜨거우며 아프지만, 후에 由實轉虛하거나 혹은 허실협잡하면 음식을 넘기기 어렵고 혹은 먹으면 바로 토하며, 중궁에 이르면 비신쇠패하고 양소음갈하여 치료가 불가능함

소화관의 통과 장애

1. 개요 프린트

[기출] 소화관의 통과장애에 대해 쓰시오



- 연하곤란 = 구강을 포함한 식도의 통과장애에서 발생하는 증상
↳ 중풍환자 or 다른 신경학적 증상이 없는데 연하곤란 호소 시 구강~식도에서 원인 찾아야 함
- Ileus = 장관(소장, 대장)의 통과장애에서 발생하는 증상

2. 연하곤란

1) 정의와 분류

- 연하곤란: 음식을 삼키기 힘든 것으로, 음식을 한꺼번에 구인두에서부터 상부 식도 및 식도 체부로 이동시키는 것에 어려움이 있을 때 생김
- 분류
 - 연하기능이 저하되어서 넘기기 힘든 것인가? = 기능적 장애
 - 협착 등의 기질적 원인에 의해 통과장애가 발생한 것인가? = 기질적 장애
 - 심인성 연하곤란

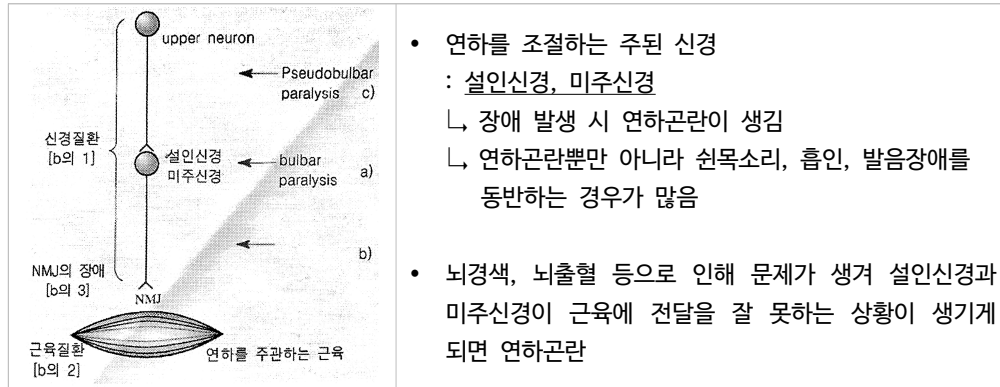
2) 기능적 장애에 의한 연하곤란 - 신경, 근육, 신경근 접합부의 장애에 의해 발생

▶ 신경질환

- | | | |
|--------------------|---------------------|--|
| ① 다발성 뇌경색 | ④ 기타 구마비, 가성 구마비 | ⑥ 당뇨병성 신경병증 ¹ |
| ② 근위축성 측색경화증(ALS) | 를 일으키는 질환 | ⑦ recurrent laryngeal n. paralysis의 장애 |
| ③ Wallenberg's syn | ⑤ 파킨슨병 ¹ | |

1) 노인분들이 연하곤란으로 내원하였을 때 먼저 중풍 검사를 시행하고, 이후 파킨슨병과 당뇨병 유무를 반드시 확인해야 한다.

신경핵에 장애가 발생	근위축성 측색경화증, Wallenberg's syn
말초에 장애가 발생	종양의 압박, 당뇨병성 신경병증
신경핵보다 상부 신경세포에 장애가 발생	다발성 뇌경색
추체외로 증상으로 운동장애와 연하운동에도 장애가 발생	파킨슨병



▶ 근육질환

- ① 근육퇴행위축
- ② 경피증: 경화성 변화가 식도의 평활근에서 현저하기 때문
- ③ 다발성 근염, 피부근염
- ④ 기타 myopathy, dystrophy

▶ 신경근 접합부의 질환

- 중증 근무력증 / 보툴리누스 중독: 둘 다 안검하수를 동반함

3) 기질적 장애에 의한 연하곤란 - 협착, 압박 등의 기질적 변화에 의해 연하곤란 발생

▶ 식도질환

- ① 식도이완불능증(achalasia): 연하곤란이 주 증상
- ② 게실(diverticulum): 아주 커지지 않는 한 연하곤란 없음
- ③ 식도궤양(esophageal ulcer): 창상 치료과정에서의 협착 발생
- ④ 식도암(esophageal cancer): 종양 증대와 함께 증상 악화
- ⑤ 평활근종(leiomyoma): 평활근의 이상비대로 인해 생긴 양성종양으로 주로 평활근이 존재하는 자궁, 위창자관, 피부 등에 호발
- ⑥ Plummer-Vinson syn: 철결핍성 빈혈의 말기 합병증으로 식도 내강에 물갈퀴와 같은 것이 생겨서 연하곤란 발생

▶ 기타

- ① mediastinal tumor, thyroid tumor: 식도를 밖에서 압박함
- ② 쇼그렌 증후군
- ③ 타액선에 방사선을 조사한 후) ex. 경부암 치료 시 타액선이 손상되어 타액이 나오지 않음

4) 심인성 연하곤란 - 내용 X

3. Ileus 장폐색

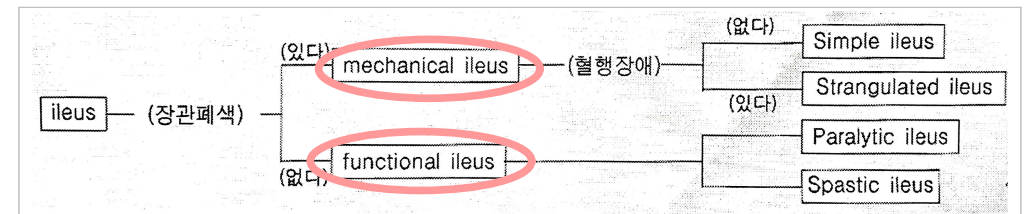
정의	• 장관내강의 폐색이나 장관의 운동장애 등으로, 정상적인 장관 내용물이 항문 쪽으로 통과하지 못하는 병적인 상태
증상	• 장관이 폐쇄되면 폐쇄 부위보다 위쪽으로 수분 및 공기가 축적되어 장이 팽창되고 구토가 발생 • 장 확장으로 인해 복부내압이 증가되어 호흡장애가 오고, 많은 수분이 마비된 장으로 빠져나가서 탈수증이 생김 • 탈수증이 심한 경우에는 혈액량 부족으로 저혈압이 생길 수 있음 • 구토: 상부에서 폐쇄되었을 경우의 증상 • 복부팽대, 산통: 하부 장 폐쇄의 초기증상
진단	• 병력청취, X-ray
치료	└ 단순폐쇄: 초기 보존적 치료 └ 감돈된 장폐색: 응급상황으로 긴급 수술

ㄷ)

- 주로 소아에게 많이 발생 or 어르신 중 심한 변비, 게실 때문에 장쪽 염증이 발생하여 유발됨
- 장관폐색은 장이 꼬여서 생기는 경우가 대부분. 노인분들이 변을 못 보는 경우에도 유사한 증상을 나타내므로 감별을 해야 함. xray 찍어보면 공기들이 꽉 차 있거나하는 등으로 보자마자 금방 진단할 수 있음

▶ 분류

[기출] Ileus의 분류와 각 분류에 따른 질환을 쓰시오



(1) Mechanical ileus - 장관폐색에 의한 통과장애

- 장관 내에 종양이 있거나, 장관이 비틀려 있건, 비정상적으로 팽팽하게 당겨져 경련이 일어나는 등 기질적인 원인에 의한 장관 폐색에 의한 통과장애
 - Simple ileus: 혈행장애 X
 - Complex ileus: 혈행장애 동반 O
- ⇒ 혈행장애로 인해 장관괴사를 일으켜 천공, 복막염, 쇼크로 급속하게 악화되므로 수술 필요

(2) Functional ileus - 장관폐색은 없지만, 연동운동 저하로 인한 통과장애

- 기질적인 원인이 없이, 장관의 연동운동의 저하로 인한 통과장애
 - paralytic ileus: 장관운동이 정지되면서 통과장애 발생
 - spastic ileus: 장관에 경련이 일어나 통과장애 발생

▶ ileus를 일으키는 질환**【기출】 Ileus의 분류와 각 분류에 따른 질환을 쓰시오****(1) Mechanical ileus을 일으키는 질환**

① 유착 adhesion	⑥ 염증성 장질환	⑪ 소장종양
② Meckel's diverticulum ¹	⑦ 식이성, 이물질	⑫ 협착
③ 탈장감돈	⑧ gall-stone ileus	⑬ 무공항문
④ rectal cancer	⑨ 장축염전 ³	⑭ 태변
⑤ 장중첩증 ²	⑩ 소장궤양	⑮ 기타(분석, 무형성, 근육, 신경)

- 창만증, 장관과다가스 환자들에게서 호발함. 노인의 경우 장관이 늘어져 있어 계실로 인해 유발될 가능성 ↑
- 장의 일부분이 근접하고 있는 장 내부로 미끄러져 들어간 것
 - 남자) 여자 - 남자에서 2배정도 더 호발
 - 원인: 정확하진 않으나 장벽에서 림프조직의 비대를 일으키는 adenovirus와 관련됨. 이 비대된 조직이 장 내로 튀어나와 장의 연동운동으로 근접한 장 내부로 밀려 들어가게 됨
 - 증상: 주기적 복통(15분 간격의 복통), 복부 촉진 상 소세지 모양의 종괴
 - 치료: 수술 (치료하지 않으면 24시간 내 분변과 유사한 구토물, 괴저, 복막염 발생)
- 장축염전: 장의 고리가 장간막 축을 주위로 돌아서 꼬이는 것
 - 염전 → 폐쇄 → 침범된 부위의 혈관폐쇄 → 혈액공급중단 → 장관사, 복막염 → 갑작스런 심한 산통

(2) Paralytic ileus를 일으키는 질환 - 넘어감

① 복막염	④ 기타 심근경색, 뇌혈관장애	⑥ 칼륨부족
② postop.paralytic ileus	등 일과성인 것	⑦ 요독증
③ 복강내출혈	⑤ 연하곤란에서도 생기는 질환	⑧ 약물(항콜린제제)

연하곤란**1. 개요** 프린트

교수님께서 거의 안 보시고 넘어가셔서 제가 임의로 간략하게만 정리하겠습니다..!

정상 연하운동	인후두의 수의근 구조, 후두 또는 기도를 보호하는 횡문근, 식도의 괄약근군과 연동 자체의 공동 작용에 의한 하나의 복합기능
연하곤란의 원인	연하운동에 관여하는 어느 요소의 장애나 부조화 or 염증성 협착이나 종양에 의한 내공의 협소의 결과
임상적 특징	- 대개 폐쇄성 병변이 있는 부위에서 느끼게 됨 - 통증 수반 가능: 특히 폐쇄된 부위 하부로 음식물을 밀어 내려는 연동파에 의해 식도 경련이 생길 때 통증이 생기기 쉬움 - 통증이 심하면 경부, 하악각부, 상복부 등으로 방산될 수 있음 - 통증 자체가 연하곤란 일으킬 수 있음
분류	① 구인두성 연하곤란증 ② 식도성 연하곤란증

2. 구인두성 연하곤란증

정의	인두의 구조이상에 의한 연하곤란
원인	- 가장 많은 원인: 근 및 신경의 장애 ① 신경장애: 뇌간 뇌혈관 사고, 종양, 가성구마비, 근위축성 측삭경화증 다발성 경화증, 소아마비, 중증근무력증 ② 근육장애: 근병증, 다발성 근염, 갑상선 기능 저하증 ③ 운동장애: 상부식도 괄약근 기능장애 ④ 구조적 이상: 췌cker계실, 악성종양, 수술, 구인두 부위의 방사선 조사
증상	- 삼킬 때 기도로 잘못 삼김 / 비강으로의 역류 / 연하 시 인두통 - 혀가 음식물을 인두로 넘기지 못하게 됨 / 연하 시 재채기, 숨막힘 등 - 발성장애, 구음장애 또는 다른 신경증상 동반
관련 질환	- 뇌혈관장애, 가성구마비, 구마비, 운동계 질환, 디프테리아성 다발성 신경염 - 궤양성 병변은 통증을 일으켜 연하장애를 일으키기도 함 - 종양, 육아종성 질환, 계실증, 갑상선 종대에 의해서 인두 or 상부식도 내강의 협착에 의해서도 생김

3. 식도성 연하곤란증

정의	식도의 내강을 막는 기계적 병변 또는 식도의 운동 장애에 의해 발생		
증상	- 음식물 삼킬 때 <u>흉골하부</u>에 국한된 팽만감을 느낌 - 음식물을 위로 내려보내지 못하기도 함 - 일차적으로 고형 음식에 대해 연하곤란 호소 (반복적, 진행되면 심해짐) - 통증 수반: 음식물을 토해냄으로써만 경감 - 대체적으로 점차적 발작		
원인	① 기질적 변화에 의한 연하곤란증 ② 외부 압박에 의한 연하곤란 - 기계적 폐쇄: 고형물이 액체보다 더 넘기기 힘들 ③ 식도의 연하운동 이상에서 오는 연하곤란 - 운동장애: 고형물 및 액체 모두에 연하곤란 O		
진단법	① X-선 검사	검사	⑧ 식도 조영술 - 요새 X
	② 식도경 검사	⑤ 위장관 내시경	
	③ 생검	⑥ 식도운동 검사	
	④ 총혈구수와 생화학적	⑦ 단순 흉부 촬영	

연하곤란 및 식도성 흉통

日) 추가적으로 볼 내용만 짚고 가겠다! - 읽으신 부분만 정리함

1. 연하곤란의 생리기전 교과서

- 연하의 진행은 자발적 구강단계로부터 시작됨

음식물이 인두로 밀려 내려감 → 음식물은 구인두부의 감각수용체 자극 → 연하반사 유발됨
→ 인두와 식도를 통해 음식물 삼킴 + 기도 내로 흡인되는 것 방지해줌

- ① 음식물이 혀에 의해 뒤로 넘어가면 동시에 후두는 앞으로 전진하고 상부식도괄약근이 열림
- ② 음식물이 인두로 넘어가면 수축된 연구개 쪽으로 상부인두괄약근이 수축하며 연동운동을 일으킴
- ③ 이후 음식물을 빠르게 인두에서 식도로 넘김
- ④ 음식물이 식도로 넘어오면 하부식도괄약근은 열리고, 연동운동에 의해 음식물이 위로 넘어갈 때 까지 열린 상태로 있음

2. 식도성 흉통

[기출] 식도성 흉통의 진단, 감별치료, 특징을 쓰시오

- 식도역류, 식도경련을 포함함
- 흉통은 가슴의 왼쪽이나 오른쪽보다는 중앙선에 위치하며 대개 흉골 후방에서 느껴짐
- 잠재적으로 치명적인 허혈성 심장질환으로 인한 동통과의 감별이 중요

1) 심근경색, 협심증 모두 특징적인 증상만 나타나는 것이 아님

ex. 위원통으로 왔다고 하면 위원통을 일으킬만한 이유가 있나 문진 후, 특별한 이유가 없다면 반드시 심장 이상에 대해서도 고려를 해보아야 함

▶ 진단 및 감별치료

식도성 흉통	• 주로 50대에 흔함 • 통증: 흉골하연 / 타는 듯 or 쥐어짜는 듯함 / 등, 팔, 턱으로 방사통 O • 운동에 의해 유발되거나 악화되는 경우 O • 니트로글리세린이 식도의 근육을 이완시켜 통증이 완화될 수 있음
허혈성 흉통과의 감별점	• 연하작용과 관련 O, 매우 차거나 더운 음료수를 마심으로써 유발됨 • 연하곤란이 있거나 위내용물의 역류를 관찰할 수 있음 • 식도손상의 경우 구토에 의해 생기며 급성 흉통을 유발할 수 있음 • 몸을 앞으로 구부리거나 눕거나 배에 힘을 많이 줄 때 심해짐 • 음식을 먹은 직후에 잘 나타나기도 함 • 침을 삼키거나 물을 마시거나 제산제를 복용하면 증상 ↓

식도질환

읽으신 부분만 정리함

1. 범발성 식도경련 프리트

- 식도운동의 장애로, 노령 신경절 퇴화, 점막자극, 유문폐쇄, 당뇨병성 신경장애 및 근위축성 측색경화증과 같은 신경 근육 장애의 증세로 나타나고, 이 중 아무것도 없을 경우에는 특발성이라고 함
- 연하에 의해 정상적으로 연동이 시작되나, 연동파가 식도하 1/3부에 접근 시 진행성 수축 대신 경련성 혹은 동시성 수축이 일어남
- 무확장증과 반대로 하부식도괄약근의 이완은 정상 / 식도 평활근의 비후

2. 식도개실

3. 식도협착증

4. 식도궤양

정의	• 소화성 궤양이 식도하부에서 발생하고, 소화성 식도염과 달라 보다 선명하게 국한되고 깊이 천통되며 천공 또는 대출혈을 일으킬 수 있음
증상	• 연하곤란 • 심와부 or 배부 견갑골간 동통 / 심할 때는 물도 삼키기 어려움 • 천공 or 대출혈 제외하고는 생명에 직접적 위험 X

5. 식도암

1) 개요 - 특징, 원인

특징	• 전 식도질환의 약 반수를 차지하는 악성 종양 = 한의학에서의 “열격” • 남자가 여자의 5~8배, 위암에 비해 고령자에 다발함 • 음주, 흡연이 유력한 위험인자 • 호발부위: 생리적 협착부 - 기관분기부 및 횡격막 관통부 부위 • 식도하부에서는 반수 이상이 선암이며 이 부위의 위점막에서 발생하고 있음
원인	• 모든 암과 같이 원인불명 (외인성 발암인자와의 접촉이 주된 원인) • 알코올 섭취, 흡연, 뜨거운 음식물 섭취습관 등에서 발현율 높음

2) 편평상피암과 선암

편평상피암 (90%)	선암
• 기관의 양분 부위와 식도상부의 암종 • 분화가 불량함 • 식생활과 연관성 O + 남성에서 흔함 • 알콜과 담배소모가 많은 남성	• 식도 하부의 암종 (식도원위부 1/3) • 위점막에서 발생 • 바렛식도의 악성 전환의 결과로 발생 • 위분문부의 선암으로부터 확장되어 발생

3) 증상

조기 증상	• 확실한 증상이 없음 • 연하 시 위화감, 흉골하 억하감, 불쾌감, 만복감이 주로 나타남 • 따가운 느낌 / 음식물이 가슴 속을 쓸어내림 / 경미한 가슴통증 등을 호소
만기 증상	• 본격적 연하곤란이 나타남 - 고형물에 대한 연하곤란 뚜렷 • 종양세포의 증식과 연하곤란이 겹쳐서 체중감소 현상이 뚜렷해짐 - 체중감소: by 연하곤란, 식욕부진
합병증	• 기관식도루 / 반회신경마비 등
기타 증상	• 병변 부위의 궤양 때문에 생긴 빈혈이 흔함 • 점진적 혈액 손실을 야기하여 철 결핍성 빈혈을 나타낼 수 있음 • 인두 분비물의 흡인으로 인한 호흡곤란과 기침

✓ 식도와 타 구조물의 위치관계

기관	반회신경
• 식도 전면 - 기관 • mid 1/3 부위의 경계: 기관 분기부 하단 • mid 1/3 부위 이하: 기관 및 기관지와 접하지 않음	• 미주신경의 줄기인 반회신경 • 우) subclavian a.에서 반회 • 좌) 대동맥궁에서 반회 후 식도와 기관 사이에 생긴 구(crena)를 상행

✓ 기관식도루

- 식도암이 기관에 침윤하여 구멍이 생겨 누공이 형성됨
- 누공을통해 음식물이 기관 내로 들어가 폐렴 발생

cf) 갑자기 쇠목소리가 나는 환자: 노래방, 감기 등 그럴만한 이유가 전혀 없다면 기관식도루 고려해볼 수 O

✓ 반회신경 마비

- 반회신경 → 하후두신경: 윤산갑상근을 제외한 모든 후두근을 지배함
- 증상: 쇠목소리
- 왼쪽에 다발: 대동맥궁은 기관분기부와 높이가 같아 하부식도에 생기는 암에는 발생 X

3) 경과

	① 표재암과 조기암 - 식도암은 점막근판에 침윤할 때부터 전이가 나타나고, 점막하층에 침윤하는 중재에서는 약 40% 이상에서 림프절 전이가 나타남 ✓ 표재암: 점막하층까지 침윤한 것으로 림프절 전이 유무 불문 ✓ 조기암: 표재암과 침윤부위는 동일하나 림프절 전이는 없는 것
	② 상피내암과 점막암 - 표재암: 점막하층까지 침윤을 가리킴 ✓ 상피내암: 점막상피, 기저막까지 침윤 ✓ 점막암: 점막근판까지의 침윤
④ 림프절 전이 - 식도암에서 흉부 림프절을 비롯해 경부, 복부 림프절에도 암이 전이함 - 식도암의 외과적 근치술에는 경부/흉부/복부의 림프절도 절제함 - 전이는 혈행성보다 림프행성 쪽이 많음	③ Skip lesion - 식도의 점막하층에는 림프관이 풍부하데, 이 림프관을 통해 skip lesion이 발생 - 즉, 림프절 전이가 있을 가능성이 높다는 뜻 - 일반적으로 예후가 좋지 않으며 식도암에서 skip lesion은 특징적으로 나타남
	⑤ 혈행성 전이 - 소화관 암이 가장 많이 전이되는 부n이: 간 - 식도암은 식도 하부의 혈류 중 일부만이 portal v.으로 들어가므로 전이 많지 않음

4) 진단

- | | | |
|----------------|-------------|----------------|
| ① 식도조영 (X선 검사) | ③ 세포검사 | ⑤ 내시경적 초음파 |
| ② 내시경 검사 | ④ Barium 검사 | ⑥ 흉부 spiral CT |

✓ 종양의 TNM 분류

- 많은 악성 종양의 치료는 그 병기에 따라 결정됨
- 치료 방법을 비교할 때는 주로 같은 병기의 환자에 대해 비교하는 것이 타당함

✓ 병기의 결정

- 식도암이 확진되면 치료방법의 선택을 위해 병기 결정을 해야 함
- CT: 간, 폐로의 전이, 림프절 종대, 국소 전이, 흉부와 간으로의 전이 여부 평가
- 내시경적 초음파: CT상 원격전이나 광범위한 국소전이가 없으면 종격동으로의 국소 전이 및 국소 림프절 전이 파악
- 기관지 내시경: 근위 식도암의 경우 기관기관지 침범 배제하기 위함

5) 치료

- 진단이 늦게 이루어지기 때문에 완치가 어려움
- 대개 증상 완화 요법인 고식적 치료임 = 대증 치료가 우선이 됨

✓ 바렛식도

발생률	하부식도에 지속적인 위산 역류가 있는 환자의 약 15%에서 발생
원인 병인	- 지속적 자극으로 식도의 편평상피가 점액으로 덮혀 있는 원주상피 형태의 위 상피세포로 전환됨 - 이러한 화생변화가 때로 악성변화에 선행되는 이형성 변화를 수반할 수도 있음
합병증	식도선암의 가능성 O

6. 식도천공 및 파열

원인	- 식도천공: 식도염, 소화성 궤양, 종양에 합병되는 경우 - 식도파열: 외상 또는 잦은 검사기구 삽입 시 의 손상에 의해서 유발 or 특발성
증상	① 강도의 동통: 대개 흉골하 or 상복부, 전흉부 - 음식의 연하에 의해 증강됨 ② 종격동 내의 자유공기, 압찰음 및 1~12시간 이내에 촉진할 수 있는 피하기증 ③ 압박 및 위액에 의한 종격동 흉막의 소화 및 이로 인한 수기흉 또는 혈기흉 및 호흡 곤란이 올 수 있음 ④ shock / 2차 감염증
치료	- 초기에 강력히 치료하지 않으면 치명적 - 조기 발견된 경우 즉시 개흉하여 봉합함 - 늦게 발견되면 흉관을 통한 배농을 즉시 시행하고 위액 흡인, 비경구 영양공급, 항생제 등 투여 - 상태 호전 되는대로 수술 봉합 시도

7. 식도정맥류

- 간경변증으로 인한 문맥압 항진으로 발생하며 이 외에 간장매독, 문맥 또는 비정맥의 혈전 등으로 인한 간문맥압 상승에 2차적으로 발생하는 중요 병변
(근데 중증이므로 거의 볼일 X)

이후 질환들은 읽어보라고만 하시고 넘어갔습니다..
프린트 읽어보시면 될 것 같아요!

아래 교과서 내용부터는 교수님께서 거의 안하고 넘어가셔서 읽어보시는 것을 추천드립니다..

식도종양(=열격)

1. 예후 교과서 p329 - 예후만 언급하심 ㅠ.ㅠ

- 악성 종양(식도암)의 5년 생존율은 아직까지 5% 미만
- 식도암은 암 발생 후 연하곤란 등의 임상적인 증상이 나타날 때까지의 시간 간격이 너무 길며, 식도의 위치가 흉곽 내이기에 증상이 없는 기간에 일반적인 진찰만으로 접근하기 어려움
- 식도에 장막이 없어 주위 조직으로의 암확산이 쉬움
- 주위의 발달된 림프계를 통해 암 전이가 쉽게 이루어짐
- 식도에 인접한 장기들이 생명 유지에 필수적인 중요 장기들이고, 방사선 조영술만으로는 식도암을 조기에 진단하는 것이 쉽지 않음

∴ 예후가 불량함

日) 식도암은 조기진단이 중요하고 생활습관 식이습관의 변화를 주어 예방하는 것이 더 중요하다.

식도 운동성 질환

교과서 p319 읽어보라고 하고 넘어가심 ..

(악마에는 관련 내용 X)

- 횡문근의 이상 / 평활근의 이상으로 나뉘볼 수 있음 - 日) 구별만 해라!

13주차 SUMMARY

위암

1. 개요 - 위암의 개요와 분류 프린트

ㄷ) 예전에는 위암 진단 시기가 늦어지는 경우가 많으나 요새는 건강검진과 건강에 대한 관심이 높아짐에 따라 초기에 진단되는 경우가 많다. 이때 초기 진단되므로 조기 생존율이 높다. 진단의 시기가 치료 경과와 예후에 중요한 역할을 한다.

1) 종양의 분류 - 아래 표는 반드시 암기!

[기출]위에 생기는 종양을 점막 상하로 분류하시오

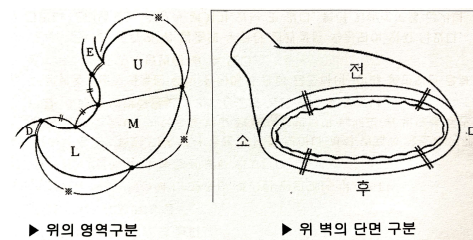
	양성	악성
점막상	위폴립	위암
점막하	평활근종, 지방종, 미입체	위림프종, 평활근육종

2) 위암의 정의와 특징

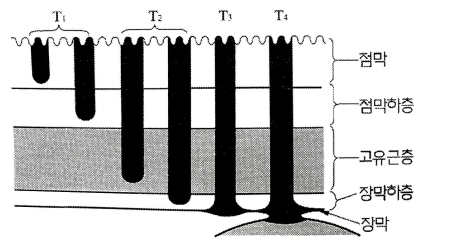
정의	위암은 위의 점막상피에서 발생한 악성종양으로 우리나라에서 전 악성종양 중 가장 호발하는 암종임
발생 원인	- 자극설, virus설 등 ① 한의학: 岩, 巖, 陰疽, 石疽(악성종양), 적취, 징가, 현벽 등도 암과 상통 ② 위암: 위안옹, 위독옹, 음벽, 열격 및 반위 등 ↳ 담음과 식적과 사혈로 인해塊가 형성된 것으로 봄
특징	- 위점막의 세포가 암세포로 변해서 위 속에 자꾸만 퍼져 나갈 뿐만 아니라 주위까지 번져나가 복막, 간, 임파절까지 침범 - 과거 한때 서구 문명사회에서 내장암 중 가장 흔했으나 지금은 아일랜드와 핀란드를 제외하고는 대다수의 서구 각국에서는 감소하는 추세 - 성: 남성이 2배 정도로 높다. - 연령: 50~70세에 호발 - 노화에 따라 세포변이가 많이 생기기 때문 - 사회계층: 저소득층에 더 흔하며 특정한 산업과는 무관 ↳ 건강검진이 잘 이루어지지 않아 그런 것임 (요새는 거의 X) - 가족적 요소: 특정 가족에서 높은 빈도를 보이거나 사회 경제적 요소가 관계하고 있는 것 같음. 가족력을 갖고 있는 악성빈혈이 때때로 위 암증을 동반하고, 이때는 일반집단보다 3배 정도의 높은 빈도를 갖는다 - 가족력 있으면 젊어서부터 조심 - 만성위염: 만성위염은 위암 환자에서 흔히 공존하여, 이때 동반되는 장화생은 악성화의 전구병변이 될 수 있음

- 음식 : 음식의 종류와 위 암증의 뚜렷한 연관성은 X but 조리법과는 관계 O
↳ 특히 지방성분을 굽거나 튀기는 관계가 있음
↳ 탄 음식, 자극적인 음식, 젓갈, 아민류 등이 원인이 됨
- 소화성궤양: 위암증은 소화성 궤양의 약 1% 미만으로 발생함

3) 위암의 병기 분류 및 영역 구분

위암의 병기분류	위의 영역, 단면 구분
- 위: 상부(U), 중부(M), 하부(L)로 3등분 - 위절단면의 테두리: 전벽(Ant), 후벽(Post), 소만(Less), 대만(Gre)로 나누어서 표시 - 두 영역을 침범하였을 경우: 주된 부위를 먼저 표시한다 (ex: MU, LM, MUL) - 식도나 십이지장에 침범 시: 각각 E 또는 D로 표기 - 위의 둘레를 거의 다 침범시: Circ로 표기	 ▶ 위의 영역구분 ▶ 위 벽의 단면 구분

4) 위암의 T 병기 분류

T 병기 분류	
- T1: 암이 점막 또는 점막하층까지만 국한 - T2: 고유근층 또는 장막하층까지만 국한 - T3: 장막을 침범 - T4: 암이 주위 장기를 침범	 점막, 점막하층, 고유근층, 장막하층, 장막, 주위 장기

5) 위암의 육안분류

0형	표재형: 병변의 육안형태가 경도의 용기나 함몰을 보이는 병변, 조기 위암을 말함.
1형	종류형: 명확한 용기가 보이는 형태로, 주위 점막과의 경계가 명확한 병변
2형	궤양한국형: 국한성 발육을 보이는 암으로 큰 궤양 형성이 있는 것. 궤양의 주위는 제 방향으로 용기하고 암의 침윤 범위는 용기 기시부까지의 것으로 본다.
3형	궤양침윤형: 주위의 침윤성 발육을 보이는 궤양형성형으로 주위 점막과 경계가 불분명
4형	미만형: 미만성의 침윤발육을 보이는 암으로 궤양은 있어도 적은 병소의 일부에 국한되어 있다. 병변과 주위 점막과의 경계가 불분명함 (진단이 조금 늦어짐)
5형	미분류암: 상기 0-4형의 분류에 속하지 않는 암.

5-1) 위암의 분류 ★★

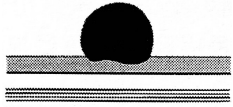
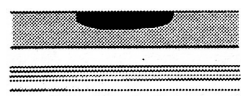
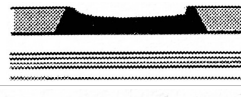
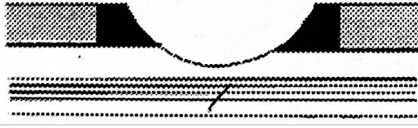
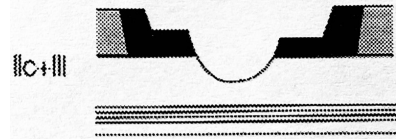
[기출] 위에 발생하는 암의 종류에 대해 쓰시오

[기출] 위선암에서 조기위암과 진행성 위암을 구분하여 서술하시오

위암	① 위선암	a) 조기위암	(b) 진행성 위암
		점막이나 점막하층까지만 침범	점막하층 이상을 침범
	② 비점막성암 (점막하층양, 악성림프종)	평활근육층, 위림프종	

2. 조기위암

1) 조기위암의 육안분류 - 내시경적 분류 [기출] 조기위암과 진행성 위암을 구분하여 서술하시오

I. 용기형		- 주위 점막보다 현저히 융기된 것 - 명확한 용기와 궤양 형성을 동반
II. 표면형	a. 표면용기형	 - 약간 용기를 보이는 것 - 용기의 높이는 점막층이 2배정도까지의 것
	b. 표면평탄형	 - 용기도 함몰도 없이 완전 평탄 - 다소의 요철이 있으면 유사 IIb, 타병소의 일부로 IIb가 나타난 것을 수반 IIb라고 함
	c. 표면함요형	 점막의 범위의 함요를 보이는 것
III. 함요형		 궤양의 병변에 암이 국한해 있음

2가지 이상의 육안형이 존재하여 있는 경우, 면적이 넓은 병변부터의 순서대로 기재한다.

Ⅱc type 위암, 위축성 위염의 구분이 중요!

▶ IIc type 조기위암과 유사병변과의 감별

	점막주름의 가늘어짐	위축 영역	점막면의 성상	위축점막 내 소화성궤양
IIc형 조기암	궤양중심으로 함몰 침단: 벌레먹은 상	연속성	광택소실, 백태, 소출혈	대부분 단발 (90%)
위축성 위염	궤양의 중심에 향하여 불락한 가늘어짐 침단: 원할	비연속성	광택 O	단발
반응성 림프종	볼록 or 오목함	비연속성 드물게 연속	광택O, 백태, 작은출혈O	불규칙한 얇은 궤양 다발

▶ 용기형 조기위암 프린트에 있는 사진과 같이 보세요!

- 내시경시 쉽게 눈에 띄기 때문에 진단이 비교적 쉽다 (cf. 작은 과립상의 용기, 평탄 용기)
- 조기 위암 1형, IIa형
- 내시경시 용기형 병변이 있을 경우 감별진단에서 주의해야 할 사항 4가지

① 용기형 병변의 개수	② 병변의 크기와 색조 병변의 크기
- 원발성 위암: 80% 이상 단발성 - 전이성 암, 악성 임파종 등: 통상 다발성 - 양성 질환 중에는 선종: 대부분 단발성 - 미란성 위염의 경우: 다발성인 특징	- 병변의 크기: 일반적으로 악성도와 비례 - 상피성 병변: 2cm - 비상피성 병변: 5cm이상인 경우 악성 의심 - 색조: 조기 위암이나 과형성 용종의 경우 적 색조를 띠 - 선종: 갈색조or살색을 띠는 경우가 많음
③ 표면구조	④ 주위점막의 성상
- 평탄형, 과립상, 결절상 등을 보일 수 있는데 평탄형보다 과립상이, 과립상보다는 결절상을 보이는 병변이 악성일 가능성이 높음 - 용기의 내부에 함요를 포함하고 있는 경우도 악성을 의심해야함. 특히 함요의 표면이 불규칙할 때는 악성을 우선적으로 의심해야 함	상피성 양성 병변인 경우: 일반적으로 용기의 경계가 명확함

▶ 궤양상을 보이는 조기 위암

- 궤양성 병변은 대부분에서 함요 그 자체와 그곳을 향하여 집중되는 점막주름으로 구성
- 함요부분은 순수한 양성 미란이 되며, 이차적으로 발생하는 궤양성 병변에 의하여 점막집중현상이 나타남
- 조기암의 함요면은 요철이 부정하며 분화형 암에서는 위소구의 모양을 하는 반면, 미분화암에서는 그 요철이 더욱 심하고 미란이 생기기 쉬움
- 집중하는 점막주름은 함요면을 향하여 가늘어짐, 곤봉상비대, 중단, 융합 등으로 나타남
- 넓은 궤양의 경우 양성 궤양과 감별이 어려움 - 수회의 조직검사 필요

▶ 위염상을 보이는 조기 위암 프린트 사진 확인하기!

- 점막의 확실한 변화가 없이 발적, 퇴색, 또는 과립상의 변화 등 미세한 변화만으로 보이기 때문에 위염으로 진단하는 경우가 많음
- 점막 변화에서의 위암 의심 소견
: ① 국한성 퇴색상 ② 경계가 불분명한 발적 ③ 국한성 발적을 보이는 미란성 병변 등
↳ 이와 같은 소견을 보이는 경우 위선종, 악성 림프종, 반응성 림프조직 과형성, 미란성 위염 등을 감별해야 함

- 위암은 수술 시기를 놓칠 경우 환자에게 완치의 기회가 없어지는 것이기 때문에 이러한 초기의 미세 변화를 주의 깊게 관찰하여 조기 위암을 진단할 수 있어야 하며 의심이 되는 경우는 반드시 조직검사를 시행해야 한다. 이와 같은 미세한 위암을 진단 한 경우는 대개 정막 절제술이나 수술로 완치를 기대할 수 있다.

✓ 수술 시기 놓친 위암 환자 Case

- 유도 선수 출신 병원 근무자, 몸 건강 + 운동 꾸준히 해온 환자
- 병원 근무 중 소화 안된다며 소화제 먹음. 이후 1~2주 지나서도 먹어서 침 몇 번 맞고 넘어감
- but 이후 2개월 정도 지속해서 소화제 먹고 있어서 교수님이 내시경 해보라고 함
- 내시경 결과 위염만 진단됨 but 계속 증상이 지속되고 안색이 안 좋아짐
- 증상이 지속되어 5~6개월 이후 검사 다시 했는데 위암 4기 진단 = 미만형 위암으로 위 점막은 정상 상 태이나, 그 밑으로 미만성으로 위암이 퍼져있던 상태 (복부 CT 상으로 이미 다 퍼져있음)
- 1개월 뒤 사망하심
= 수술 시기 놓친 환자는 완치의 기회가 사라짐. 내시경으로 미만성 위암은 진단이 힘들

3. 진행 위암

- 진행위암은 고유근층 이상 침범한 암으로 수술하더라도 굉장히 많이 절제해야 함
- Borrmann 분류상: 3형이 가장 많고 2형 > 4형 > 1형
- 5형: 위암에서 1형에서 4형 사이 분류하기 어려운 암으로, 대부분 조기 위암 유사 진행인 경우가 많음 (약 15%)

▶ 진행위암의 Borrmann형 분류

[기출] 조기위암과 진행성 위암을 구분하여 서술하시오

분류	특징
① Borrmann I: 용기형 	- 국한성의 발육을 보이는 용기형 암으로 표면에 분명한 궤양 형성이 없는 것 - 대개 2-3cm 이상의 큰 종괴를 형성 - 표면은 매우 불규칙하고 출혈이 관찰되거나 검은 혈괴 등이 부착되어 있는 경우가 많음
② Borrmann II: 궤양 한국형 	- 국한성 발육을 보이는 암으로 큰 궤양 형성이 있는 것 - 궤양 주위는 제방상으로 용기하고 암의 침윤 범위는 용기 기시부까지의 것 - 궤양성 종괴로 주위 정상 점막과 경계를 이루는 제방성 용기가 관찰되며 궤양저에는 부정형이 백태나 혈액이 부착되어 있는 경우가 많음 - 궤양의 변연은 매우 불규칙한 것이 특징 - 조직검사: 궤양, 주위 제방의 경계부위 or 궤양저에서 시행

③ Borrmann III: 궤양침윤형



- 주위의 침윤성 발육을 보이는 궤양 형성형의 암 (가장 많음)
- 궤양의 모양은 Borrmann II형 위암과 유사하다.
- 암은 궤양주위의 용기부분에도 침윤을 보이며 주위 점막면에서 암이 관찰된다.
- 궤양저로부터 연속된 암이 주위점막에 침윤되어 병변과 주위 점막과의 경계가 불명확한 경우도 있다.

④ Borrmann IV: 미만형



- 미만성의 침윤발육을 보이는 암 = 경성암
- 궤양은 있어도 적은 병소의 일부에 국한되어 있는 것
- 점막면에서 정상 세포를 남겨 놓고 주로 점막하층으로 미만성으로 침윤되는 형태 내시경으로 공기를 넣었을 때 신전되지 않는 위의 모양을 보임
- 예후: 비교적 불량
- 가족주머니와 같이 위벽이 암으로 인하여 굳어진다고 하여 라이나이트스 플라스틱형이라고도 함
- 경성암의 초기에는 육안적으로 뚜렷하지 않으며 조직검사로도 약 반수에서만 암세포가 발견된다.
- 흔히 몇 달 전에 위 내시경 검사를 해보았는데 아무 이상도 없었는데 증상이 나빠져서 다시 검사를 했더니 위 전체에 퍼져있는 암이었다는 경우
- 비교적 젊은 연령층, 특히 50대를 전후한 여성에서 흔함

4. pm암

- 위암이 고유근층까지만 침범된 경우
- 5년 생존율이 75%정도로 조기암과 진행암의 중간정도 예후를 나타냄
- pm암은 조기위암과 유사한 모양을 갖는 것과 Borrmann의 분류에 따른 형태를 갖는 것이 있음

5. 조기 위암 유사 진행암

- 대부분이 Borrmann III형이나 육안적으로 조기암병형에 유사한 병소를 가 지는 pm 이상 침범된 진행위암
- II c 진행이 가장 흔한 형태
- 유사조기암: 육안적으로는 틀림없는 조기암으로 진단하였으나 그 후 조직학적 검색으로 진행암으로 판명된 경우
- 조기형 진행암: 육안적으로도 이미 진행으로 진단이 가능하지만 조기암의 병형에 유사한 경우

6. 위유암

- 충수돌기에 가장 많고 소장, 직장, 위 등 위장관 어느 곳에든지 발생할 수 있는 내분비 종양
- 점막하종양이므로 점막하종양의 특징을 모두 가지고 있으며 단발하고 그 중앙부에 함몰이 있는 경우가 많음
- 육안적 - 황색 내지 황갈색의 색조

✓ 교수님의 썰파티

- 1) 암 진단 후 금연하게 된 지인
 - 지인 중 담배 못 끊던 사람이 폐렴 쪽 결절이 있었는데, 이것이 암으로 진단받게 됨
 - 이후 금연함 근데 알고보니 오진! 단순 결절이었음..
 - 그래도 이런 계기로 금연하게 되는 것 나쁘지 않을지도?
- 2) 환자 주변인의 중요성
 - 중풍환자, 노인환자, 자보환자들 .. 등등의 환자들의 경우, 그들의 가족들/간병인들의 적극적 지지와 정신적 지지 등을 받으면 호전 정도가 굉장히 좋음
 - 명약도 환자가 심리적 안정의 상태일 때 잘 듣는다
- 3) 교수님이 요새 빠진 한방내과 추나 - 근데 이제 재활과 몰래 하는..
 - 소화가 안되고 가스가 차는 등의 내과질환은 흉곽과 척추의 기능/정렬과 관련이 많음
 - 식욕부진, 피로감의 환자에게 추나로 척추를 풀어줬을 때 약 썼을 때보다 효과가 좋았음
 - 스킨쉽이 있으므로 환자와 가까워질 수 있음

7. 점막하종양 종류만 알아두자

- 위 점막에서 발생된 것이 아니고 점막근판 이하의 조직에서 발생하는 종양
= 점막은 정상인데, 그 내부에서 생긴 종양
- 내시경을 통해 우연히 발견되는 경우가 대부분
- 종양의 표면색조 및 현관상 등이 주위와 동일한 정상 점막으로 덮여 있으며 일반적으로 돌출된 용기 모양을 이룸
- 점막하에 위치하므로 종양에 의해 점막주름이 끌려 올라간 점막교(bridging fold)가 보인다.

양성	상피성	위낭포 미입체
	비상피성	위평활근종, 지방종, 섬유종, 신경초종, 신경섬유종, 혈관종, 림프관종
악성	비상피성 평활근육종, 기타 육종	
염증성 종양	호산구성 육아종	

1) 위평활근종 (gastric leiomyoma)	• 위의 점막하종양 중 가장 높은 빈도 • 고유근층으로부터 발생하나, 드물게 점막근판이나 혈관벽의 평활근으로부터 발생하는 경우도 있음 • 위체부에 주로 발생하며, 위내형이 많음 • 생검 경자: 단단하고 가동성 X • 드물게 종양의 정점부에 궤양이 생겨 위장관 출혈을 유발 • 악성인 평활근 육종과 감별 - 크기가 5cm 이상인 경우 / 궤형성이 있으며 크고 깊은 경우 - EUS상 내부 에코가 높고 낮음이 혼재 - 낭포상의 무에코 영역이 보이는 경우 / 빠른 발육 속도
2) 미입체 (aberrant pancreas, ectopic pancreas)	• 선천이상인 과오종 • 췌장의 원래 부위가 아닌 곳에 췌장조직이 들어있는 것 • 대개 증상이 없이 우연히 발견되지만 드물게 궤양, 출혈, 유문폐색, 염증에 의한 가성 낭종, 암 등을 일으킴
3) 위낭종	• 점막하층에 존재하는 낭포성의 점막하종양 • 청회색을 띠며 종종 투광성이 관찰된다. • 생검 경자: 매우 부드럽고, 쉽게 눌러지는 cushion sign이 보이며, 파동이 관찰되는 경우도 있음 • EUS상 저막하층에 주로 위치하며 무에코 영역으로 보임
4) 지방종 (Lipoma)	• 지방종은 점막하층에 존재, 대부분이 무경성 용기 • 때로는 유경성인 경우도 관찰됨 • 내시경상 표면: 매끈, 황/황백색 • 생검 경자: 매우 부드러워 쉽게 눌러지는 cushion sign을 관찰 • 크기가 큰 경우 용기의 점막면에 미란이나 궤양이 관찰되기도 함 • 특징적인 EUS 소견: 병변이 주로 점막하층에 위치, 고에코의 영역으로 보임

5) 기타

- 그 외에도 호산구성육아종, 신경초종, 신경섬유종, 혈관종 및 림프관종
- 때때로 분문부나 공류부에서 관찰되는 점막하종양 양상의 종괴 중에 위정맥류를 점막하종양으로 오인하여 조직검사를 시행하는 오류를 범하기도 하는데, 이 경우에는 주위에 굴곡사행하는 정맥류를 확인하는 것으로 감별 할 수 있다.

8. 위암 이외의 위종양

① 악성종양	• 위암은 위의 악성종양의 90%를 차지 + 나머지는 거의 임파종 • 육종은 비교적 드무나 그중 가장 흔히 보이는 것이 평활근육종 • 이외) 섬유육종, 신경원섬육종, 신경섬유육종, 점액육종 등 • 육종은 보통 암으로 오진 받거나 또는 우연히 발견되는 수가 많음 ✓ 위 임파종 • 위에서 발생하는 악성 종양 중 두 번째로 많이 발생 └ 원발성 림프종: 위에 단독으로 발생하는 것 └ 이차성 or 속발성 림프종: 전신성 림프종이 위에 파급된 것 • 위임파종은 대개 임파육종 or 세망육종임 • 증상: 일정하지 X. 상당히 진행된 환자도 아무런 증상 없을수도.. • 원발성 위임파종: 상복부통 또는 종류촉지, 체중감소 등이 나타나며, 환자는 초진 시 일반상태가 양호한 것이 특징이다. • 위암에 비해 대량출혈이나 천공을 일으키기 쉬우나 X선검사, 위산도검사, 위내시경검사 또는 수술소견에 의해서도 위암과 감별하기 어렵기도 함. → 따라서 위경에 의한 생검 또는 개복술이 진단에 필수적
② 양성종양	• 양성위종양: 선종, 평활근종, 섬유종, 지방종 및 신경섬유종 등 • X선 검사 및 위경검사소견으로 봤을 때 보통 양성임이 뚜렷하지만 양성일 가능성을 확실히 부정할 수 없어 종종 절제수술 진행함
③ 선종성 polyp	• 위의 원위측 ⅓부분에서 생기며 흔히 다발성 • X선 검사: 위내강에 평활한 타원형의 음영결손 • 위내시경검사상: 정상점막을 가진 딸기모양의 종유를 나타냄 └ 직경이 2cm 이상되는 polyp: 50%가 polyp양 암종 └ 2cm 이하인 것: 1%만 암성이다. • 선종은 그 자체가 암이 될 수 없다는 것이 확실하기 때문에 작은 polyp은 특별한 치료를 필요로 하지 않고 단지 추적만 필요 • 2cm 이상 되고 점점 크게 자라고 출혈성이며 X선검사, 위내시경검사 또는 생검으로 의심되는 polyp은 외과적으로 제거해야 함

9. 위암의 형태

① 용종상 암종	• 양배추 모양의 증식 양상 / 저부에서 흔함 / 조직학적 전형적 선암종 • 부서지기 쉬운 종괴가 내강 안으로 돌출함 • 과사가 흔하며 표면에는 흔히 궤양이 있다. • 표재성으로 머물고 있다가 위벽을 침입하여 주위 조직으로 확산함
② 경화성 암종	✓ 국소형 • 유문 부위에 흔하고 내강 안으로 돌출은 없을지라도 섬유화에 의한 내강의 폐쇄가 일어남 • 큰 궤양을 형성하지만 대개 근육층까지 침투하고 그 이상은 잘 침범하지 않는다. 궤양은 만성 소화성 궤양보다 크며 경계가 불분명하다. ✓ 미만형 • 암종이 식도를 침윤할 수 있다. • 위의 크기는 감소하나 위벽은 단단하게 두꺼워지며 가족주머니 위궤양 X • 현저한 위추벽 / 심부선에서 기원하는 것처럼 보이는 암종 / 표면 침범 X • 경화성 반응(섬유화)이 독특한 현상이다. • 조직학적 - 전형적인 선암종이나 인환 세포 암종 (모양은 둥글며 점액의 큰 어리에 의해 핵이 한쪽으로 밀려져 있다)
③ 점액성 암종	• 유문에서 발견되며 약간 회고 반투명하게 퍼져 있다. • 직접적인 확장에 의해 복강 내에서 두꺼운 요대의 덮개로 다른 기관을 싸며 조직학적으로 점액에 떠 있는 암세포를 가진 선세포로 구성되어 있고 때로 가락지모양의 세포조직을 갖기도 함
④ 표층성 확산형 암종	• 흔하지 않으며 점막과 점막하층에 퍼져서 사행성/포행성의 선 형성

10. 위암의 전이 및 전이에 따른 증상 ★

✓ 위암의 전이방법

- ① 벽면을 따른 직접전이
- ② 췌장, 간, 식도 등 인접 장기로의 전이
- ③ 임파관을 통한 전이 : 국소임파절, 원격임파절 전이
- ④ 복강내 세포이식
- ⑤ 혈관을 통한 전이 : 문맥-간-간비대-복수

- 위암이 국소적으로 침범하거나 혈류, 임파 및 복막을 통해서 전이되면 그에 해당하는 증후가 나타난다.
- 흔히 식도하부, 십이지장근위부, 망막, 대장, 복막, 췌장에 전이를 일으킨다.
- 폐전이는 임파성 및 미만성 또는 혈행성 및 결절성이다.
- 국소 및 원격전이에 의해서 간, 흉막, 골, 신경계 및 피부에 증상을 일으킨다.
- 췌장전이: 배부통
- 간이나 간문부임파절 전이: 황달
- 골 전이: 동통이나 병적 골절

① 직접확산	• 대개 광범위하게 일어나고, 여러 구조들이 침범됨 • 횡격막과 복벽으로 확산된다. • 범체강내 확산은 직접 확산에 의한 특이한 형태임 • 암세포는 복막강에 퍼져 수많은 조그마한 결절을 형성한다. • 인환세포 암종은 직접확산으로 양쪽 난소에 전이암 형성 = Krukenberg종양 • 점액성 암종에서의 직접 확산은 복강 내에 매우 큰 종괴를 형성한다.
② 림프관성 전이	• 초기에 발생하며, 특히 경화성 암종에서 흔히 광범위하게 일어남 • 위 정맥하 림프관이 최초로 침범되며 이것들이 위벽의 결절을 형성한다. • 그 다음에 바로 장막 림프관을 침투하게 됨. 망, 장간막, 장벽이 침범됨 • 림프관을 통한 간의 전이가 흔히 발생한다.
③ 혈행성 전이	• 혈류를 통한 전이는, 초기 간문맥 혈관계를 통해 간에 전이가 일어난다. • 얼마 뒤 폐장과 전신 순환계를 침범하므로써 뇌와 골에 전이됨 • 혈행성 전이는 퇴행성 암종에서 가장 흔히 관찰되고, 점액성이나 미만성 경화형에서 덜 흔하다

11. 위암의 병기 (stage)

- ① 제1기 : 암이 위점막 및 점막하층에만 국한되고 임파절이나 원격전이가 없는 위암
- ② 제2기 : 암이 위근육층 및 장기에 침윤되었으나 주위 장기에는 침윤 안되고 임파절 및 원격전이가 없는 위암
- ③ 제3기: 암이 위영역임파절에 전이되어 있는 위암
- ④ 제4기 : 원격전이가 있는 위암

✓ 교수님의 고민

- 체력이 좋지 않은 노년층 암환자에게 항암 방사선 치료와 같은 침습적 치료가 맞는가?
- 젊은층은 침습적 치료를 견뎌낼 수 있지만, 노년층 환자의 경우 그렇지 않은 경우가 많음
- ex) 교수님 지인의 아버지가 암환자 but 체력 약했던 분
 - 항암치료 1주일 후 6개월 간 쓰러져 병상에만 계시다 돌아가심
- 노년층 환자가 아닌 40~50대 암환자의 경우 사람의 회복력에 따라 초전되기도 함
- 암환자를 보고 무조건적으로 치료를 권해야하는가에 대한 생각을 해봐야 함

12. 위암의 증상

- 조기위암에 있어서는 무증상인 수가 많으며 암이 상당히 진행된 경우에도 일련 건강하게 보이고 이렇다 할 증상이 없는 수가 있다(잠재암).
- 실제 환자가 고통을 느껴 병원을 찾을 때는 이미 암침윤이 위벽으로 확대 되어 있는 수가 많다.
- 위암은 초기에는 아무런 증상이 없다가 진행되면서 괴사, 출혈, 궤양 또는 내강협착, 주위 또는 원격조직, 장기로의 전이 및 진행암의 영향으로 인한 국소적 및 전신적 증상이 나타난다.
= 증상은 위암의 경증과 비례하지 않음

1) 주증

① 상복부 飽脹과 동통

- 不適과 동통, 초기에 위암은 흔히 현저한 증상이 없다.
- 상복부 포창, 부적 등 과식은 증상 가중시킴 (이를 소화불량으로 오진하여 무시하기 쉬움)
- 환자는 흔히 자동적으로 절식하여 부적을 경감시키킴
- 동통은 흔히 지속성 은통으로서 일반적으로 절률성이 없는데 이는 궤양병과 다른 점

② 식욕부진: 식욕감퇴, 특히 육류를 싫어하는 것이 위암의 중요한 조기증상

③ 오심, 구토: 경도의 오심은 위암에서 결코 드물게 나타나는 증상 X

- 유문전암의 암종은 유문폐색을 일으키며 환자에게서 흔히 구토가 나타남
- 구토물은 대개 속식한 것 + 산미를 지님 + 커피색 (암종의 표면, 세포탈락, 출혈로 인한)

④ 연하곤란: 암종이 분문/위저로 확대되어 위입구가 저해받아 음식물 섭취 시 폐색감이 있고, 이것 이 점차 발전하여 진행성 연하곤란이 됨 (연하곤란될 정도면 병이 상당히 진행된 것)

⑤ 구토 혹은 흑시: 암종이 대혈관 침입 후 대출혈 일으켜 흑색으로 변함

13. 위암의 진단

- ① 병력청취
- ② 이학적 소견: 혈액 및 대변검사 / 위액분석 / X-ray검사 / 내시경 검사 / 생검 및 세포진
- 조기의 진단은 본 병의 치료와 예후에 영향이 크므로 반드시 경각심을 갖고 책임정신을 가져야 하며 상세히 병력을 하여 환자를 검사해야 한다.
- 연령이 40세 이상이고 특히 남성환자가 단기 내에 원인불명의 상복부 포창, 부적, 소수, 식욕부진 등의 상황이 나타나거나 혹은 위궤양병력의 적극적인 치료에도 불구하고 치료의 효능이 현저하지 않을 경우 마땅히 조기에 주의를 요한다.

14. 위암의 감별진단

- ① 위궤양
- ② 위염
 - 만성위염: Xray 검사 시 위암과 쉽게 구별되지 않는 충영결손과 위벽변화가 나타남
 - 위산의 증가: 위염 > 위암
- ③ 간장 및 담낭종양: 황달, 복수를 수반함 + 고도의 호흡성 이동에 나타남 + 상한선 촉진X
- ④ 췌장암: 유문암으로 오진하기 쉽지만 심부에 있어 대개 피이동성이 없음

15. 치료

- 절제수술, 방사선 동위원소 치료, 약물치료, 화학요법, 면역요법 등
- 변증
 - 痰滯交阻(담이 울체하여 막힘): 병의 초기에서 볼 수 있음
 - 기혈어체(기혈이 막힘): 병의 후기에서 볼 수 있음

16. 경과와 예후 / 예방

- 병의 확인을 내린 후 6개월~1년 이내 사망하는 자가 많으며 2년 이상 생존하는 경우는 드물다.
- 완전한 절제만이 치료가 가능하다고 하나 조기진단이어야 하며, 다른 부위로 전이하면 예후는 극히 불량하다.
- 평소 폭음폭식X, 자극성 음식물 X
- 만성위축성위염, 문치 등에 대해서는 철저히 치료를 행하는 동시에 장기간 검사를 행함
- 위궤양에 대해서는 마땅히 적당한 조치를 취하여 위암의 발생 가능성을 조기에 발견해야 함
- 위암이 많은 우리나라에서는 위의 건강관리를 위해서 연령이 40세 이상이 되면 주기적으로 건강검진을 받는 것이 위암을 예방하는 가장 좋은 방법

위암

1. 원인 교과서 p.1350

- ① 환경적 및 유전적 요인: 위암 발생의 중요인자
 - 위암 유발 발암물질: 니트로소아마이드, 니트로소아민, 이종환식 아민, 고농도 식염 등
강력 발암물질, 세균에 의해 만들어짐 단백질, 지방 탄 것
 - 유전적 요인: 인종, 위암의 가족성, 악성빈혈, 저감마글로불린, 젊은 여성의 경화성 위암 등
 - 日) 요리 후 전자레인지에 돌려먹는 음식이나 냉동실에 오래 둔 음식 등은 피하기..
- ② H.pylori의 감염
- ③ 전암병변

이후 내용은 프린트와 유사하여 교수님께서 그냥 넘어가심!
한 번 읽어보시면 될 듯 합니다.

반위^{反胃}

1. 개요 교과서 p.133

정의	- 反胃 = 胃反 - 음식이 위에 들어간 이후 비교적 장시간이 지난 뒤에 다시 토하는 것 - 대부분 음식부절, 주색과도, 장기간 우사율노로 비위의 기가 손상되어 기체/어혈/담응을 초래하여 발생 - 주요 임상표현: 위완비창, 속식불화, 조식모토, 모식조토
서양의학적 분석	- 위/십이지장 궤양, 위십이지장계실, 급/만성위염, 위종양, 위신경증 ↓, 유문부 경련/부종/협착을 병발해 위의 배출기능장애를 일으킬 수 있음

2. 병인병기

1) 비위허한	음식노권, 정지실조 등으로 비위가 손상 받으면 비위가 허한하여 수곡을 부속하지 못해 음식이 위내에 정체하고 속식이 소화되지 않아 반위 발생
2) 위중적열	- 장기간의 과음, 흡연, 자극적 음식의 섭취로 발생 - 나머지 병인에서 전화하여 발생하기도 함 - 맥, 설, 증 모두 열상을 띠
3) 담탁조위	- 비위가 손상받아 수곡이 운화되어 정미로 변화하지 못하고 습탁을 형성함 - 습이 축적되면 담이 발생하고, 담이 위를 조색하면 위의 통강하행 기능이 실조되어 속식이 소화되지 못하고 반위가 발생
4) 어혈적결	- 위의 병기들이 한 단계 더 변화한 결과로 발생 = 전암성 병변이 관리가 안되었을 때 이런 암증으로 발전할 수 있음

3. 진단

- 대부분 완만히 발병
- 먼저 위완통, 토산, 조잡, 식욕부진, 식후완복비창 등의 증상이 생김
- 만약 치료하지 않아 병정이 진행되면 점차 완복비창이 심해지고 식후에 특히 심하며, 음식이 소화되어 내려가지 못하고 위에 정체되어 결국 상역해 구토를 일으킴
- ↓, 여기서의 구토: 조식모토, 모식조토 + 소화되지 않은 토물, 담연/혈이 섞임 + 심할 경우 토혈
- 환자는 구토로 먹으려 하지 않아 수척해지고, 얼굴이 누렇게 뜨며 권태롭고 무기력함
- 음식이 위에 정체해 완부를 누르면 불편해하고, 때로 덩어리가 만져짐

日) 환자의 증상도 봐야 하지만, 소화기 질환만큼 환자의 전체적인 컨디션(수척해지는지, 영양공급이 잘 되고 있는지 등)을 확인해야 한다.

4. 감별진단

[기출] 열격과 반위를 비교설명하시오. (병리, 증상, 특징, 치료원칙, 복용법)

1) 구토	- 구토는 반위를 포괄함 - but 반위와 다르게 식사 직후 토하고 먹지 않아도 토하며 토 양이 적음
2) 열격	- 음식이 흉격에서 막혀 내려가지 않는 것 - 주된 표현이 연하곤란으로 음식이 분문으로 들어가지 못함
3) 번위 翻胃	- 반위와 혼동이 잘 되어 반위를 번위라고 칭하는 경우도 있음 - 번위는 구토에 가깝고 반위와는 다름

5. 변증요점과 치료원칙

[기출]반위의 변증요점과 치료원칙을 쓰시오

변증요점	- 구토의 성질과 구토물의 정황에 주의 - 병력을 자세히 문진하는 것 필요 - 반위의 증후를 구별해야 함 (한열담어) - 기타 증상, 맥상, 설질, 설태, 환자의 현재/과거 병력, 체질
치료원칙	- 降逆和胃^{강역화위} 가 기본원칙 - 양기가 허하면 온중건비를 함께 쓰고, 음기가 부족하면 청양위음을 함께 씀 - 기체하면 이기를 겸하고, 어혈이나 담탁이 있으면 활혈거담을 겸함 - 병이 제거된 뒤에는 반드시 위기와 위음의 자양을 위주로 해야 함 - 복약 시기의 파약도 중요 - 반위 환자는 속식이 위에 정체해 있으므로 이때 복약 시 흡수 용이 X - 따라서 공복 시에 복약 or 속식을 깨끗이 토해낸 뒤 다시 복용해야 함

日) 소화기 환자들이 많이 입원해있는데 보약을 즉 한약 자체를 먹기도 힘들어하는 사람도 있음
식욕부진이나 오심구토 환자가 있는데 이런 환자들에게는 뭘 먹게 죽는 것보다 힘들다고 할 정도로 힘들어함
이런 환자들에게 약을 어떻게 먹일까가 관건이다.

6. 변증

다 아는 것이라고 지나가셔서 간단히 써드립니다!

[기출] 반위의 변증시지 중 변증형을 나열하시오 or 반위의 변증시지 4가지를 적으시오

- ① 비위허한 ② 이중적열 ③ 담탁조위 ④ 혈어적결

7. 경과 및 예후

- 초기에는 단순히 비위허한형이나 위중적열형을 나타내며, 그 병변이 무형지기에 있으므로 온법이나 청법을 쓰면 비교적 쉽게 치료됨
- 시일이 오래되면 담탁조위형이나 어혈적결형을 나타내며, 그 병변 모두 유형지적에 있으므로 비교적 치료가 어려움
- 병이 오래되어 전신이 날로 쇠약해지면 4가지 증형이 섞여 함께 나타날 수도 있음

8. 예방 및 조리

- 음식조절에 주의, 흡연/음주/자극성 식품 피함, 마음을 편하게 유지하고 방실노권 삼간다
- 병을 얻은 후에는 제때 진단/치료를 받고 청담한 유동성 음식을 먹으며 거친 음식은 피함
- 구토를 할 때는 환자를 부축여 토출이 원활하도록 도와줌
- 약은 농축시켜 공복에 복용

14주차 SUMMARY

복통 腹痛

1. 개요 교과서 p.155

曰) 복통을 일으킬 수 있는 요인은 오장육부 모두에 있음. 이때 통증이 있으면 원인을 진단하는 것이 첫 번째! 통증의 특징별로 복통의 원인을 찾아야 함. 이를 위해 삼위일체법의 치료법에 준해서 확인해볼 수 있음

정의	- 복통이란 위안 이하로부터 치골모제 이상의 부위에서 발생하는 통증 - 임상에서 매우 흔하게 접할 수 있는 증상 - 대부분 육음, 충적, 식체에 상하거나 or 기체혈어, 기혈휴허로 경맥실양하여 발생
병정	복통의 병정은 복잡하고 범위가 매우 넓으므로 임상에서 변증 시 그 병인과 통증 부위에 통증의 성질 및 주요 受病臟腑에 근거하여 전면적인 고려를 한 후 팔강변증에 의해 시치를 행해야 함 = 원인을 찾는 것이 가장 중요!

2. 병인병기

1) 感受外邪, 阻逆爲痛	한열서습의 사기가 복중에 침입해 비위운화가 실조되고 중초에 유체하면 기기가 막혀 복통이 발생함
2) 素體陽虛, 寒從内生	비양이 불운하여 장부가 허한하거나 중양이 허해 한습이 정체하거나 기혈이 부족해 장부의 온양작용이 실조하면 복통 발생
3) 恐食辛辣, 裏熱內結	리열이 뭉쳐 위장에 적체하여 불통하거나, 신랄한 음식을 함부로 먹어서 습열과 식체가 서로 엉겨 기기의 소통이 불리하고 전도의 기능을 수행하지 못하여 발생
4) 음식부절, 식체불화	꼭음꼭식하거나 비감후미가 정체하여 소화가 되지 않거나, 불결하고 부패한 음식을 잘못 먹으면 비위를 손상함
5) 기체혈어, 비조위통	기혈은 전신을 운행하는데, 잘 이루어지지 않으면 울분으로 간을 상하여 기기가 상역하고 문란하여 장부의 기능이 실조하면 복통이 발생함
6) 충적	주로 회충으로 인한 복통 - 요새는 드물다

2) 노인들은 주로 신체기능이 떨어져 있는 상태(=음허 or 신음허 등)이므로 육미, 팔미를 쓰거나 충분한 수분공급해줄 수 있는 약제가 있어야 함

3. 변증요점 및 치료원칙

▶ 변증요점

1) 복통의 성질을 분별해야 한다. **【기출】복통의 성질에 따른 분류와 그에 대한 설명을 쓰시오**

- ① 한통: 뱃속 켁김, 뱃속 부글거림, 끓어질 듯 아픔 = 주로 “絞痛”
 - 실증(기가 역상해 구토, 뱃속 단단, 창만, 땅기며 아픔), 허증(은근한 통증)
- ② 열통: 배꼽노리가 아프며 아픈 부위가 뜨거움, 혹 변비/찬 것 마시기 좋아함 = 주로 “制痛”
- ③ 어혈통: 아픈 부위가 옮기지 않고 아랫배가 찌르듯 아픔, 손으로 누르는 것 싫어함, 통증이 야간에 심해짐, 얼굴색 어둡고 입술이 자색임 - 설질 맥상 확인 필수!
- ④ 기체통: 통증이 가벼웠다 심했다 함, 부위가 고정되어 있지 않으며 여기저기 돌아다니며 아픔, 가슴과 옆구리가 편안하지 않고 트림과 복창이 있으면 방귀/트림
 - 침을 놓기 전에는 복진을 해야 함. 복진 시 침 놓고 난 뒤 어느 정도 호전될지 가능할 수 있음
 - 복진 시 매우 배가 딱딱할 때 소견중탕 쓰면 빨리 풀리기도 함
- ⑤ 傷食痛: 장위가 아프고 썩은내 나는 트림
- ⑥ 虛痛: 일반적으로 오래된 통증, 통증이 은근히 지속하여 멎지 않음, 손으로 누르는 것 좋아함
- ⑦ 實痛: 갑작스런 통증, 대개 복창과 구역질이 있고 손으로 누르는 것 싫어함
 - 손으로 눌러보고 허/실을 판단하기엔 애매한 부분이 있어 환자를 진찰하고 판단해야 함

2) 복통의 부위를 분별해야 한다.

① 少腹痛	• 아랫배의 통증은 간경의 증상	
	장공 (=충수염)	우측의 소복통으로 누르면 심해지고 발을 구부리고 누우며, 열이 나고 속이 메스꺼우며 대변이 시원스럽지 않음
	疝瘕 疝	아랫배에서 배꼽 가까이 좌우에 통증이 있는데, 누르면 장형의 결괴가 잡히고 弓弦처럼 단단하며 종종 옆구리 밑까지 당김
② 제복통	乾霍亂 絞腸痧	뱃속이 쥐어짜듯 아픔 / 토하려하나 토하지 못하고, 설사하려고 하나 설사하지 못함 / 번조증이 나서 답답함 / 심하면 얼굴이 푸르고 참담 / 팔다리 차가움 / 머리에서 땀이 남 / 맥이 침대함
	충적통	통증이 아팠다 그쳤다 함, 심해서 참기 힘들다
	寒疝	뱃속에서 경련이 일고 배꼽노리가 아픔, 식은땀, 찬 것을 겁냄, 팔다리가 차고 맥이 침긴함
③ 小腹痛	하초축혈	배꼽 밑 아랫배가 아픔, 통증이 발작하고 땅기고 뭉쳐서 단단그득함, 소변은 잘 나옴
	림증	열이 방광에 응결해 소변불리하고 아랫배가 발작적으로 땅기며 아픔
완통은 위에 속함 / 제통은 비, 장에 속함 / 험통, 少腹痛은 간에 속함 / 小腹痛은 자궁과 방광에 속함		

▶ 치료원칙

[기출] 복통의 치료원칙에 대해 쓰시오

- ① 한열허실을 구분해야 함
 - 실: 功 / 허: 補 / 열: 寒 / 한: 熱 / 滯: 通 / 積: 散
- ② 通/補의 관계에 주의해야 함
 - 불통증통은 실증동통의 병리이므로 실통은 通利해야 함
 - 공허법 외 溫通, 활혈통락, 이기산결 모두 통법의 범주에 속함
 - 허통은 補해야 함

4. 변증시치

[기출] 복통을 실증, 허증으로 나누어 변증시치 하시오.

- 1) 실증: 한실복통 / 실열복통 / 기체복통 / 어혈복통 / 식체복통 - 밑줄 = 교수님 언급 가장 多

(1) 寒實복통	증상	복통비극, 대변불통, 협하편통, 수족궤냉, 태백, 맥현긴
	치법	온리산한, 통변지통
	치방	대황부자탕, 삼물비급환
(2) 實熱복통	증상	복부비만창통, 거안, 조열, 대변불통, 구건인음, 수족궤연한출, 矢氣頻轉
	치법	청열통부(臍)
	치방	대승기탕, 청중탕, 금령자산
(3) 기체복통	증상	복통검창민불서, 功蠱不定, 통리소복, 애기즉서, 정서급조加극, 맥침실유력
	치법	소간해울, 이기지통
	치방	사역산, 천태오약산
(4) 어혈복통	증상	소복적괴동통, 통처불이, 설질청자, 맥삭
	치법	활혈화어
	치방	소복축어탕, 소시호탕가미, 수념산가미대황도인, 도인승기탕가미소목홍화
(5) 식체복통	증상	완복창만동통, 거안, 애부탄산, 厭食嘔惡, 통심육변, 득대변통감
	치법	소식도체
	치방	지실탕 가 목향 사인, 송복보화환, 지실도체환

- 2) 허증: 허한복통

(1) 허한복통	증상	복중시통혹면면불휴, 희득온안, 按지즉통減, 면색무화, 신피, 외한, 기단, 설담태백, 맥세무력
	치법	온중보허, 완급지통
	치방	소건중탕, 대건중탕, 이중탕, 당귀사역탕

5. 복통의 분류

- | | | | |
|--------------------|--------|--------|---------------------|
| ① 한복통 ¹ | ③ 사혈복통 | ⑤ 담음복통 | ⑦ 칠정복통 ³ |
| ② 열복통 ² | ④ 식적복통 | ⑥ 충복통 | ⑧ 허복통 ⁴ |

- 1) 한복통: 과민성 장 증후군, 세균성 감염 등
- 2) 열복통: 급격한 복직근 경직, 장폐색증 등. 여름에 차가운 것 먹고 생김

✓ 원인이 정확하지 않은 설사 Case

- 유사 장티푸스와 같이 미열, 하루에 3~4번 묽은 변을 보는 환자
- 4개월 간 설사가 지속되어 내시경 3번, CT 촬영, 대학병원까지 모두 거쳐 온 환자
- 원인이 정확하지 않은 설사에 설사 횟수를 멈추기 위한 기본 처방으로 위령탕 사용
- 의외로 빨리 호전되어 퇴원함

- 3) 칠정복통: 의외로 매우 많으며, 일반 담음복통과 같은 환자들보다 이런 간기울결쪽 환자의 치료가 더 빠름
- 치방) 사역산, 분심기음 등
- 4) 허복통: 위염 위하수 위무력증 등

6. 복통류증 - 日) 종류만 알아둬도 됨! 해놓고 기출 나눔;

- | | | |
|---------------------|-----------------------|----------|
| ① 복통嘔泄 | ③ 腹皮마비혹통 ² | ⑤ 涌水症용수증 |
| ② 복중협착 ¹ | ④ 복중鳴 | |

[기출] 복중협착에 대해 설명하시오.

- 1) 복중협착: 장관이 흡착된 것, 수술 혹은 궤양 후 치유기에 나타나는 위장관 협착을 의미함
- 한의학적으로 담습타기가 심비를 공격하는 것으로 봄
 - 이진탕 가감을 사용함
 - 소아에게 많이 발생하고, 급성 위염 후에 다발함

- 2) 복피마비혹통
 - 복부에 감각이 없는 것

✓ 복피마비 환자 Case

- 교수님이 척추 문제가 아닐까 했는데 모든 검사에 정상이었음.
- 복부 감각이 없었음. 비증까진 아니어도 누군가 날 만지는 것 정도 인지하는 환자였음
- 처음에는 추나, 협착혈 약침 등을 했는데 호전이 없이 끝났음

- 3) 복중鳴
 - 식습관에 의해 생기는 장관 과다 가스 (장내 유산균의 기능에 따라 차이가 있는 것 같음)

✓ 헬스장에서 침 놓은 Case

- 아침에 당근 먹고 체한 것 같다고 운동하다가 식은 땀 흘리고 주저 앉은 사람에게 침 놔주고 병원 홍보함

복통 腹痛

1. 개요 프린트

- 복통 = 복부에서 느끼는 동통(보통 복부의 불쾌감도 여기에 포함)
- 급성복통: 건강하던 사람에게서 급격히 발생하는 소위 급성복증
- 만성복통: 비교적 장시간에 걸쳐서 지속
- 복통의 성상: 쥐어뜯는 것 같은, 도려내는 것 같은, 찌르는 것 같은, 콧콕 쑺시는, 뜨끔 뜨끔한 등의 표현이 다양
- 학술적 표현: 산통, 강한 지속통, 둔한 지속통의 세 종류로 나눈다

2. 복통의 분류

【기술】 복통의 발생기전에 따른 분류를 쓰고, 각각 예를 들어 설명하시오.

1) 발생 기전에 따른 분류: 내장통, 체성통, 관련통

- 상호중복으로 나타나며, 일반적으로 내장통으로 시작해 체성통으로 이행하며 연관통이 혼재함

(1) 내장통	원인	- 자극을 받는 장기에서 발생하는 통증으로써, 내장성 장기의 확장, 신전, 경련 등에 의하여 impulse가 생겨 이것이 교감신경을 상행하여 일어나는 주기적 경련성 동통 - 어떤 원인으로 인해 내장장기의 평활근에 기계적 자극이 발생하거나, 벽 내에 화학적 자극이 발생하면, 그 자극이 뇌에 전해져 통증을 느끼게 됨 - 간, 췌장, 신장 등 실질장기의 피막 자극에 의한 통증도 내장통으로 분류됨
	증상	- 염증, 폐색(이상 내장장기), 장기의 종창(이상 실질장기) 등 - 주요 증상 특징: 둔한 통증 / 정중선상 / 비국한성 / 간헐성 / 산통 - 오심, 구토, 발한 등의 자율신경 증상을 수반하는 경우가 많음 (내장은 칼로 잘라도 통증이 없으나 오히려 잡아당기거나, 심하게 수축하거나 팽대되면 통증을 유발하게 됨) - 대개 둔통이며 통증의 장소를 확실히 알기가 어려우나 내장통은 원칙적으로 복부의 중앙선상에 위치하게 되는 경향이 있음
(2) 체성통	원인	- 어떤 원인에 의해 벽측 복막이나 장간막에 물리적, 화학적 자극이 뇌에 전달되어 통증이 되는 것 (ex. 복막염) - 통증의 장소를 확실히 알 수 있으며 예리한 동통이 지속적임 - 외복막통이 뚜렷할수록 복부 내 질환이 외복막에 파급되고 있는 현상을 의미
	증상	- 복통 환자를 접했을 때, 내과적인 처치를 해야 하는 것인지를, 복통의 특성을 보고 어느 정도 판단할 수 있어야 한다. - 일반적으로 내장통은 내과적 치료를 하지만, 체성통은 외과적 치료가 필요한 - 날카로운 통증 / 국한성 / 지속성 통증

(3) 관련통

- 관련통 = 연관통, 투사통, 반사통
- 자극을 받는 장기와 전연 다른 부위에 확산되는 통증으로서 자극을 받는 장기 에 공급되는 신경의 체표면의 공통 분포 장소에 확산되는 통증.
- 장기의 통증을 전달하는 신경이 피부의 통증을 전달하는 신경과 합류되므로, 장기의 통증을 피부의 통증으로 느끼게 됨
- 연관통 부위에 따라, 어느 장기가 장애를 받고 있는가를 짐작할 수 있음
 - ex1) 우견갑골부: 담낭염, 담석 등 중앙급성 췌장염
 - ex2) 하복부~음낭: 요로
 - ex3) 왼쪽 어깨, 아래턱 통증: 심근경색, 협심증
 - ex4) **상복부 내장통: 급성 충수돌기염 초기**
4~ 5시간 후 우하복부에 국한되는 통증은 **외복막통임**
 - ex5) 상복부의 심와부 내장통: 급성 담낭염의 아주 초기 (등 통증이 특징적임)
나, 이후 우측 늑골 하부에 국한된 외복막통이 나타나며,
우측 어깨가 아프거나 우측 견갑골적하부가 아픈 것은 연관통

2) 통증 양상에 따른 분류

- 간헐적인 통증: 평활근 연속으로 내장장기의 질환이 의심
ex) 단순성 장폐쇄, 담석증, 요관결석, 위, 십이지장궤양
- 지속되는 통증: 실질장기나 복막질환이 의심
 - 통증이 지속되며, 시간이 경과함에 따라 심해지는 것: 대부분 외과적 치료를 요하는 질환임
(일반적으로 건강한 사람이 6시간 넘게 복통을 호소하는 경우)

- 일정한 통증: 염증이 많음 ex 췌장염
- 통증이 심해진다면: 복막질환¹
- 장기의 파열, 출혈: 복막을 자극
- 천공: 복막을 자극
- 혈류장애: 심근경색 통증과 유사

✓ 1) 복막질환

- 질환이 복막까지 퍼져 있다는 의미
- 충수염의 천공 or 담낭염의 파열로 염증이 복막까지 퍼져 있는(복막염) 증상, 간염의 파열로 인해 복강에 출혈이 있는 증상, 자궁 외 임신으로 출혈이 복막에까지 미치는 증상 등

✓ 진경제와 진통제

- 복통에 진경제(평활근의 연속이 원인일 때), 진통제(그 외의 원인일 때) 사용

(1) 발작적인 강한 복통	- 격심한 조이는 듯한 통증이 발작적으로 일어났다가 그쳤다가 반복되는 경우 ① 상복부통 - 급성위.식중독.당석증 등 ② 하복부통 - 신결석. 수뇨관결석 의심 ③ 충수염 - 상복부의 발작성복통에서 시작하는 일이 많다
(2) 지속적인 격심한 복통	- 지속적으로 격심한 복통이 있을 때는 장기파열, 천공 의심 - 장기파열, 천공: 복막염을 속발하기 때문에 복근 긴장을 일으켜 복벽이 단단해지며 복부를 누르면 통증이 격심해짐 ① 상복부: 위궤양에 의한 천공, 급성췌장염 등 ② 하복부: 장염전, 자궁외임신의 파열, 충수염의 천공 등 의심
(3) 지속성의 둔통	- 가벼운 복부장기의 질환은 대개 은통 - ex) 만성위염, 만성췌염, 만성 장카타르, 담낭염, 장관의 유착에 의한 통과장애, 내장하수증, 회충증, 위궤양의 초기
(4) 등/어깨로의 방산통	- 통증이 몸보다 등이나 어깨 등 다른 부위로 방산하기 때문에 그 방산하는 상태로 대강 짐작할 수가 있다. - ex) 위궤양 - 위의 뒤에 해당하는 좌배부에 방산 - 담석증 - 우상복부에서 우배부와 우견에 방산 - 수뇨관결석, 신결석 - 외음부에서 대퇴내측에 방산 - 충수염 - 허리와 우퇴내측에 방산

3. 복통의 발생기전

- 복통은 복부에서 발생하는 동통 이외에 복부 외의 질환에서 오는 방산통, 대사성 동통, 신경원성 동통 등: 뇌척수 지각신경과 자율신경 지각지를 자극함으로써 일어남
- 복부에서 뇌척수신경의 지배가 있는 부위는 복벽, 복막, 장간막기시부 뿐이고 복부 내 장기들은 지각을 갖고 있지 않으므로 동통을 느끼는데, 이에 대해서는 그들의 주위조직에 분포되어 있는 지각신경을 자극하기 때문에 일어나는 것이라 해석되고 있다.
- 복부내 몸의 영증이 복벽, 복막 또는 장간막에 파급되어 일어나고 위장의 강직성 경련은 장간막이 견인되어 압박되거나 반사적으로 복벽을 강직시키므로 일어남

4. 복통의 원인 질환

(1) 복부에서 발생하는 동증	① 외복막의 염증 - 세균전파(충수돌기 파열, 골반 등) - 화학물질의 자극(소화성 궤양천공, 췌장염 등) ② 내강장기의 폐색 - 소장 및 대장의 폐색 / 담도계의 폐색 / 요관의 폐색 ③ 복부혈관장애 - 복부혈관의 혈전증 - 심한 쇼크, 등에 의한 비폐색성 장 허혈증 - 장의 팽창 : 장벽의 허혈이 발생
(2) 복부 이외의 몸에서 복부로 되는 동증	• 흉부: 폐렴, 심근경색증에서 복통이 발생 • 척추: 척추염, 척추신경염 등 • 생식기: 고환염 등에서 복통이 발생 a. 순환기¹ ① 협심증.심근경색: 주로 골 아래로 동통, 상복부, 어깨 등으로 통증이 방사 ② 박리성 대동맥류: 박리 부위와 일치하여 통증이 나타나며, 박리가 복부 대동맥에 미치면 복통이 생긴다. ③ 대동맥류 파열: 격렬한 복통, 배부(등)통, 요통 시작, 파열 시 출혈로 쇼크 유발. ④ 장간막동맥 혈전증: 혈전이 장간막동맥을 폐색하여 장간막허혈이 발생. 폐색과 동시에 급격한 복통을 일으키며 오심, 구토, 설사, 하혈 동반 b. 호흡기 ① 폐렴의 주된 증상: 발열, 기침, 객담, 호흡곤란 - 폐렴의 염증이 횡격막에 미치면 상복부 통증을 유발
(3) 대사성 질환	① 외인성: 중금속 중독, 기타 약물중독 (특히 요새 건강기능식품 유의) ② 내인성 - 기왕력이 있으므로 쉽게 감별 가능! - 요독증: 식욕부진, 오심, 구토, 복통, 정신증상, 부종 등 - 당뇨병 혼수: 다음, 다식, 다뇨, 체중감소 - 당뇨병 케톤산증: 복통, 오심, 구토를 동반 - 포르피리아: 복통, 구토, 변비 등의 소화기 증상 및 사지마비, 불안, 두통, 환각 등과 같은 정신신경 증상을 유발 - 알레르기성 질환: 신전된 하지 쪽에 축지 가능한 자반, 관절통, 복통, 혈뇨, 단백뇨

(4) 신경학적 질환	① 기질적 질환: 매독성 타베스, 대상포진 ② 신경성 위장질환
(5) 기타	① 결절성 다발동맥염: 복부의 동맥(상하 장간막동맥)에 혈관염이 생기면, 동맥류, 협착, 폐색 및 복통이 발생. ② 횡격막하 농양: 소화관 천공, 급성 충수염, 급성 담낭염 등으로 인해 간과 횡격막 사이에 생긴 농양이다.

日)

- 장의 완전 폐색이 이루어지게 되면 열이 나며 통증이 심하여 알아챌 수 있음
- 소장, 대장의 폐색이 7~10일 이상 지속되면 하복통과 상복통이 대부분 같이 나타남

1) 순환기 계통 환자 case

- 위완통 “만” 있는 환자 내원. 내원 이전에 병원만 3군데 돌고 왔는데, 별 이상 없었다고 함
- 교수님은 의심되어서 CT 찍어보니 대동맥 파열 직전이었음

2) 소장 림프종 환자 case

- 하복통과 설사를 주소로 내원한 환자. 내원 전 병원 3군데 돌고 왔음
- 복진 시 하복부 덩어리가 잡혀서 보냈더니, 알고보니 주먹만한 소장의 림프종 발견됨

3) 불대변 환자 항문부 손상 case

- 90세 불대변 주소의 환자. 탈수증상과 식욕부진의 증상까지 겸함
- 병원에서 관장약 넣고 기다리던 중에, 환자의 보호자가 못 참고 손가락에 비닐장갑을 끼고 항문에 넣고 휘저으며 대변을 꺼냄
- 이런 과정에서 충분한 항문 마사지+글리세린이 부족해 항문에 상처를 입고 고생하심

4. 복통의 부위에 따른 원인질환 및 증상

└ 대복통: by 식적외사

└ 제복통: by 食瘕火

└ 소복통: by 어혈담

(1) 전복부 동통	• 급성으로 오는 것이 대부분이며 초기에는 어느 일부분에 국한되었다가 전복부로 파급되는 것이 많다. ① 천공성 복막염 ② 복수: 간경변증, 만성 신증후군, 요독증, 심장질환, 복막염 ③ 만성: 만성 위장염
(2) 심와부 젤 많고 감별할 것 多	• 급성 동통: 급성위염, 담석증, 췌장염, 위암 등 • 한의학적: 식상증, 심통, 심하경통, 조잡 등으로 감별치료해야 함 • 심와부는 위질환 외에 심혈관 질환, 충수염 초기에도 있을 수 있음

	① 급성위염, 만성위염 ② 위십이지장 궤양 ③ 담낭염, 담석증 ④ 췌장염 - 환자는 옆으로 누워서 구부리는 자세를 취함 (이 자세가 통증이 완화됨) ⑤ 위암, 간암, 췌장암 ⑥ 신경성 위염 ⑦ 식중독
(3) 우상복부	• 간담질환(젤 많음), 폐렴에 의한 횡격막의 자극, 요로감염, 우횡격막하 농양, 흉막염 등 ① 급만성간염 ⑤ 간암 ⑨ 수신증 ② 횡격막하농양 ⑥ 흉막염 ⑩ 기타: 난소낭종 ③ 간농양 ⑦ 신석증 ④ 간경화증 ⑧ 급성신염
(4) 좌상복부	• 비장이 위치하는 위치 • 비장, 횡격막, 심장, 요로 질환으로 통증 발생 • 신장 종양이 비장종대와 감별이 곤란할 정도로 촉진되며, 췌장염/위궤양/횡행결장/좌횡격하농양이 나타나는 부위 ① 간경화증 ② 비장만곡증후군: 습관성 변비에 의한 장내가스 체류로 좌결장만곡부 아픔
(5) 우하복부	• 회맹부, 부인과적 질환, 요로계 질환 ① 충수염 ② 난소염
(6) 좌하복부	• 부인과 질환, 요로계 질환, S상결장 관련
(7) 하복부	• 방광, 전립선, 자궁이 있는 부위로서 남녀 성기질환, 방광질환, 여성 생식기 질환 등
(8) 臍 주위	• 소장과 복막질환 • 충수염, 장폐색, Meckel게실, 소장염, 장중첩, 회맹부결핵, 결핵성복막염, 복막염 ① 소장폐색 ② 소장염: 가장 동통이 심하면서 설사, 발열 ③ 장폐쇄증 ④ 결핵성 복막염

5. 기타

1) 동통의 상호관계

- ① **음식섭취** : 소화성 궤양이나 간담도계질환, 췌장질환과 식사와의 관계
- 밤중, 새벽, 식사 전 등 공복시 통증: 십이지장궤양. 산 분비가 증가되므로 공복 시에 아프고, 식사를 하면 위산이 묶어지므로 통증이 경감된다.
 - 식후 바로 나타나는 동통: 악성질환의 진행위험, 횡격막열공탈장, 식도 혹은 위분문부의 게실, 반사성 위경련
 - 식후 30~40분 후의 통증: 위궤양(gastric ulcer) 음식물 덩어리가 위벽을 자극
 - 식후 1~4시간에 보는 동통: 십이지장 위 유문부의 소화성 궤양
 - 식후 늦게 나타나는 동통: 간, 담도, 담낭, 췌장이나 기능적 위유문부 십이지장부의 운동장애
- ② **수면장애**
- 과식한 저녁식사 후 3~5시간 후 동통: 담즙성산통(biliary Colic)
 - 자정~ 오전 3시 사이 동통(장에서 깨는 것): 십이지장궤양
 - 취침 후 즉시 동통으로 잠을 깨게 되는 경우: 활주형 횡격막탈장
- ③ **음식의 종류**: 특수한 음식에 대한 특이성 반응으로 동통이 유발될 경우도 있다.
- 액체 혹은 당질 섭취는 위절제술 후 "dumping"과 관계
 - 지방질: 담낭성 발작
- ④ **육체적 활동으로 유발되는 동통** - 협심증, 팽창된 위, 횡격막 열공탈장, 복막의 유착증
- ⑤ **승차 및 승마 등으로 동통** - 감돈된 담낭 혹은 요도 결석, 대장 게실염의 발작 등

6. 복통진단의 개괄

- 모든 심한 복통을 호소하는 환자에서는 금방 수술을 요하는 질환인가, 수술을 하되 늦춰다가 할 것인가, 내과적 치료를 요하는 질환인가, 하는 점을 빨리 알아내는 것이 가장 중요하다.

1) 병력

- ① 복통의 성질, 정도, 장소, 기간, 빈도, 확산되는 장소, 복통을 악화시키는 요소를 알아내야 한다.
- ② 위장관 및 전신증상으로서 발열, 오심, 구토, 변비, 설사 등 다른 증상을 세밀히 문진해야 함
- ③ 복부 이외의 질환으로서 복통을 일으킬 수 있는 질환들을 조사한다.
- ④ 대사성 질환 및 신경질환에 관한 문진이 필요하다.
- ⑤ 여자에서는 경도의 상태를 반드시 알아야 한다.
- ⑥ 각종 특이한 가족력을 검사한다.
- ⑦ 평소에 복용하는 약제들에 관하여 조사한다.(응고제, 각종 진통제 등)
- ⑧ 매독 및 임질의 병력에 관한 문진이 필요하다.
- ⑨ 사회경제적 문제에 관하여 알아보는 것이 중요하다.(직업, 가족관계, 사회적 응도 등)

2) 이학적 검사

(1) 시진	① 수술반흔 : 수술 후에 반흔이 보이는 경우는 장마비(ileus)이다. ② 연동항진 : 장관운동이 복벽을 통해 관찰되는 것 - 격렬한 장관운동을 일으키므로 mechanical obstruction을 의심 ③ 출혈반 ④ 전굴위 : 급성 췌장염 환자는 전굴위의 자세를 취하면 통증이 경감되기 때문에, 전굴위의 형태로 잠을 자게 된다. (Knee-chest position)
(2) 청진	① 어떤 소리도 들리지 않는다 : 장폐색 ② 장관연동음이 들린다 - mechanical ileus 연동운동이 진하면 장관연동음이 증강한다.
(3) 촉진	• 압통과 종류 유무, 장기의 종대를 보는 것도 매우 중요 • 복막자극증상: Blumberg's sign과 복벽경직, 판상경직 - 내장통에서 체성통으로 이행하면 복막자극증상이 나타나게 됨 ① Blumberg's sign : 압박한 손을 갑자기 떼었을 때 보다 강한 통증을 느끼게 되는 것 - 자극이 복막에 미친 경우에 나타난다. - 내장통에서는 압통을 느끼기는 하지만, Blumberg's sign은 나타나지 않음 - 체성통으로 이행하면 Blumberg's sign이 나타나게 됨 ② 복벽경직 : 복벽을 가볍게 자극해도 근육수축이 일어나는 것 ③ 판상경직 : 복벽에 자극이 있을 때 복벽경직이 계속되는 상태로 복근이 지속적으로 수축함
(4) 기타	① 심장, 호흡기의 검사 및 탈수 정도를 판단한다. ② 발열, ERIE, 발한, 저혈압 등을 정확히 관찰한다. ③ 복부진찰에 중요한 점 - 만져보기 전에 옷을 벗기고 잘 관찰하여 복부팽대, 육안적 장운동을 관찰한다 - 복부의 촉진은 부드럽게 가만가만히 하며 손에 힘을 주면 곤란하다 - 복부의 종고, 복수, 장기의 비대, 압통, 반동압통, 근육긴장 등을 진찰한다. - 복부청진을 통하여 장관운동과 관련된 질환을 진찰한다. ④ 수지향문검사를 시행하며, 여성에서는 내진도 필요하면 시행하는 것이 좋다. 남자에게선 고환 등 생식기를 진찰한다.

+ p.271 복통 교과서 부분 - 수업 안 하고 넘어가셨습니다!

곽란 霍亂

1. 곽란후제병 p.162

[기출] 곽란후제증의 종류와 처방, 증상을 쓰시오.

ㄹ 곽란은 사실 응급질환이므로 한방병원에 오는 경우는 많지 않음 - 교수님이 언급하신 부분만 정리했습니다

① 곽란후전근	• 폭토폭사하면 진액이 亡하고, 종근이 失養하는데, 경미할 경우 양다리에 전근이 생기며, 중할 경우 몸 전체의 전근이 생기 • 증상: 편제전근, 량각전근, 수족궤랭 • 처방: 모과탕 / 목유산 가 회향 감초 자소엽 / 부자이중탕 사물탕 가 주금, 주화, 창출 남성 / 평위산 가 목과
② 곽란후변갈	• 토사를 많이 하여 진액이 폭망하여 번갈이 생기면, 引飲不止함 ↳ 처방: 계령백출산, 오령산, 초두산, 맥문동탕, 가감유령탕, 지갈탕 • 혹, 비허기함한 자에게는 백출산을 준다
③ 곽란후허번	• 곽란 후 허번으로 잠을 못 잔다 + 혹, 열갈이 있음 + 진액부족 ↳ 처방: 죽엽석고탕, 삼호삼백탕, 기제탕
④ 곽란후위완통	• 곽란 후 위완통이 있는 자는 식물이 오래되어 어혈이 된다. • 처방: 곽향정기산 (교과서에는 도인을 씹먹고 부추액을 먹으라고 되어 있네요..)

곽란 霍亂

1. 식중독 프린트

교수님께서 프린트를 거의 안 하시고 넘어가셔서 제가 임의로 기출 내용 바탕으로 정리했습니다!

- 식중독은 6~9월에 집중적으로 발생함
- 발병 경로: 세균 or 세균이 생산한 독소에 오염된 음식을 섭취하거나, 화학독 섭취 및 식물성/동물성 자연독을 경구로 섭취함에 따라 식중독 증상을 일으키는 질환군
- 주증상
 - ① 급성: 오심, 구토, 설사, 복통
 - ② 중증: 체액상실, 전해질 실조로 인한 여러 가지 증상
- 원인에 따라서는 발열 or 혈변을 동반하기도 함

☞ 교수님의 베트남 출장 설

- 호텔에서 연잎밥 같은 것을 먹고 이후 오한 발열 하루 20번 설사
- 심선혈, 팔사풍 했는데도 안 낫고 죽겠음
- 새벽에 땀이 나서 푸쉬엄하며 땀을 매우매우 냄
- 이후 오한 발열이 조금 낮고 살만해짐 + 하루 15번씩 설사하며 의료봉사 버팀

2. 식중독의 분류 [기출] 식중독을 종류별로 분류하고 해당하는 세균과 독소를 서술하시오.

- └ 1) 세균성 (80%): ① 독소형 ② 세균(감염)형 ③ 혼합형
- └ 2) 비세균성 (20%)
 - └ 자연독: ① 동물성 ② 식물성 ③ 미생물성
 - └ 화학독
 - └ 알려지성: 건어물, 생선, 고기통조림 등

▶ 세균성 식중독의 원인균

독소형 식중독	감염형(세균형) 식중독
① 보툴리누스: 보툴리누스 독소	① 장염 비브리오
② 황색포도구균: enterotoxin	② 살모넬라
	③ 캄필로박터: 그람 음성균, 나선형균 등
	④ 대장균: 독소원성 대장균, 장출혈성 대장균
	⑤ Yersinia, Clostridium perfringens 식중독, 비브리오 vulnificus 식중독, Shigella 식중독

▶ 비세균성 식중독의 원인

- 식물성 식중독: 독버섯(무스카린, am-antia, psilocin), 감자(Salanin 독소)
- 동물성 식중독: 복어중독(Tetradotoxin), 조개류
- 화학성 식중독: 인공 착색제, 인공감미료(사카린), 방부제

3. 식중독의 치료

[기출] 식중독 치료에 대해 설명하시오.

1) 대증요법	① 탈수현상: 수분 및 전해질 교정 - 수액으로 교정 ② 화학 물질 및 독성 음식 섭취: 구토제 복용 및 위세척 ③ 피부발적, 담마진, 소양증: 항히스타민제, 스테로이드 ④ 복통 및 심한 설사의 교정 (지사제) ⑤ 호흡마비: 인공호흡
2) 원인치료	① 항생제, 항독소를 원인에 따라 투여함